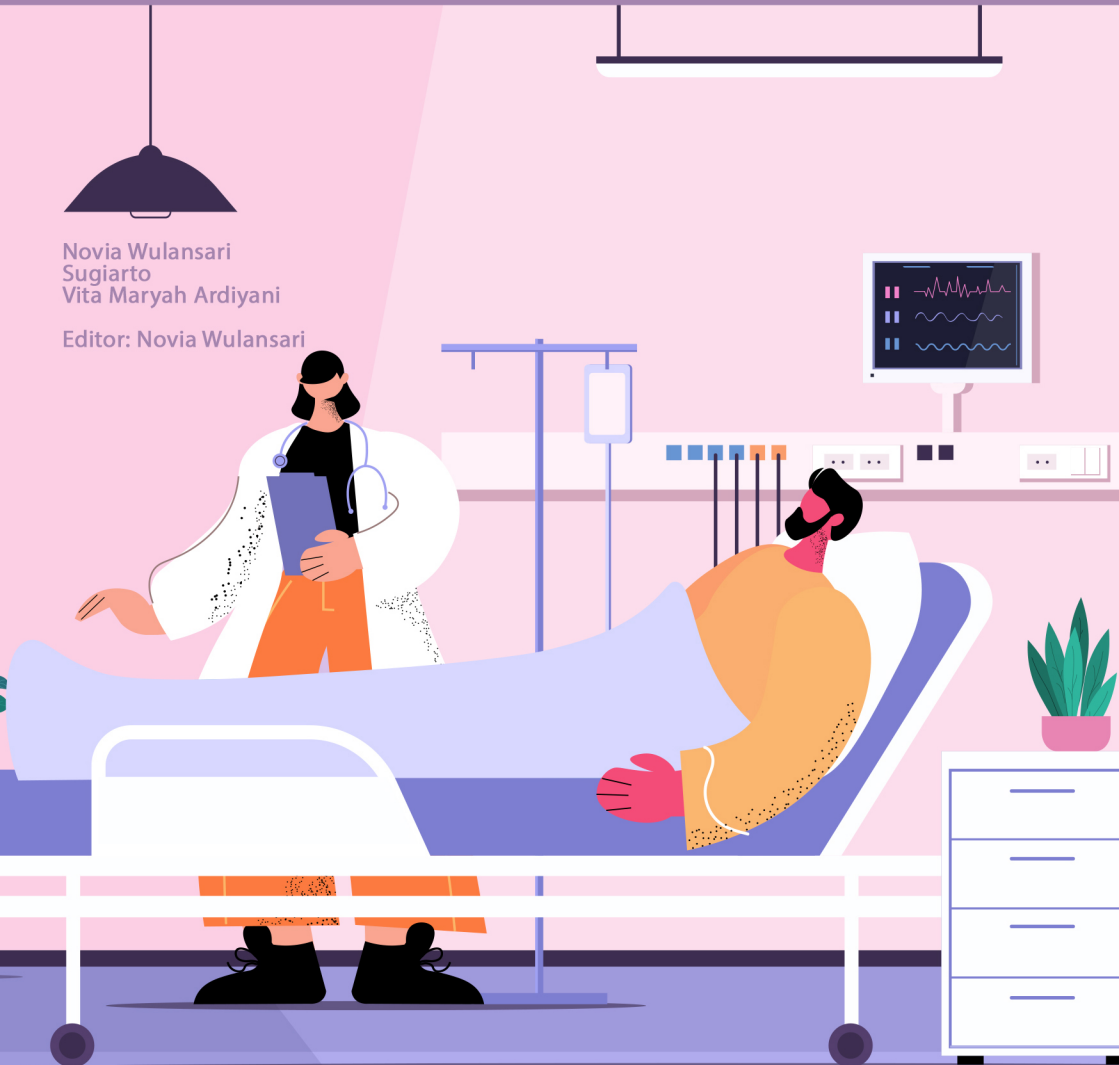


# *Bunga Rampai*

## **KEPERAWATAN GAWAT DARURAT ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB DALAM SITUASI DARURAT**

Novia Wulansari  
Sugiarto  
Vita Maryah Ardiyani

Editor: Novia Wulansari



# **BUNGA RAMPAI: KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB DALAM SITUASI DARURAT**

## **Penulis:**

Ns. Novia Wulansari, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep.

Vita Maryah Ardiyani, S.Kep., Ns., M.Kep.

## **Editor:**

Ns. Novia Wulansari, M.Kep., Sp.Kep.MB.



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

**Bunga Rampai: Keperawatan Gawat Darurat: Etika dan Tanggung Jawab dalam Situasi Darurat**

**Penulis:** Ns. Novia Wulansari, M.Kep., Sp.Kep.MB.  
Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep.  
Vita Maryah Ardiyani, S.Kep., Ns., M.Kep.

**Editor:** Ns. Novia Wulansari, M.Kep., Sp.Kep.MB.

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan  
**Tata Letak:** Helmi Syaukani

**ISBN:** 978-634-7219-25-1

**Cetakan Pertama:** April, 2025

Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2025**

**by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: [www.nuansafajarcemerlang.com](http://www.nuansafajarcemerlang.com)

instagram: @bimbel.optimal

**PENERBIT:**

**PT Nuansa Fajar Cemerlang**

**Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F**

**Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah**

**Jakarta Barat, 11480**

**Anggota IKAPI (624/DKI/2022)**



# PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku bunga rampai yang berjudul *"Keperawatan Gawat Darurat: Etika dan Tanggung Jawab dalam Situasi Darurat"* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam penguatan kompetensi dan wawasan keperawatan, khususnya dalam bidang keperawatan gawat darurat yang penuh tantangan, tekanan, dan tanggung jawab profesional. Keperawatan gawat darurat menuntut ketangguhan emosional, ketepatan klinis, serta kepekaan etis dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi yang relevan dan aplikatif bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, maupun tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan gawat darurat.

Bunga rampai ini terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama membahas tentang *Etika Keperawatan Gawat Darurat: Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Krisis*, yang menyoroti pentingnya landasan etika dalam menghadapi situasi genting dan penuh ketidakpastian. Bagian kedua mengulas *Kerja Tim dan Kolaborasi Antar Profesi dalam Penanganan Gawat Darurat*, menekankan peran komunikasi dan sinergi multidisipliner dalam menjamin keselamatan pasien. Sementara bagian ketiga mengangkat tema *Tanggung Jawab Perawat dalam Triase Pasien: Menentukan Prioritas Perawatan*, yang menggambarkan peran vital perawat dalam memilah dan menentukan prioritas layanan secara cepat dan akurat.

April, 2025

**Penulis**



# DAFTAR ISI



|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>PRAKATA.....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b> | <b>iv</b>  |

## **CHAPTER 1 ETIKA KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONDISI KRISIS ..... 1**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Ns. Novia Wulansari, M.Kep., Sp.Kep.MB. .... | 1  |
| A. Pendahuluan/prolog .....                  | 1  |
| B. Kegawatdaruratan dalam Keperawatan .....  | 3  |
| C. Referensi.....                            | 14 |

## **CHAPTER 2 KERJA TIM DAN KOLABORASI ANTAR PROFESI DALAM PENANANGANAN GAWAT DARURAT ..... 21**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep.....                                 | 21 |
| A. Pendahuluan.....                                                 | 21 |
| B. Manfaat Dan Tujuan Bekerja Dalam Tim .....                       | 24 |
| C. Prinsip-Prinsip Kerja Tim dan Kolaborasi Antar Profesi .....     | 24 |
| D. Langkah dalam Membangun Kerjasama Tim.....                       | 26 |
| E. Tahapan Perkembangan Tim .....                                   | 29 |
| F. Kolaborasi Antar Profesi dalam Penanganan Kegawatdaruratan ..... | 30 |
| G. Simpulan .....                                                   | 40 |
| H. Referensi.....                                                   | 41 |
| I. Glosarium.....                                                   | 45 |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHAPTER 3 TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM TRIASE PASIEN: MENENTUKAN PRIORITAS PERAWATAN.....</b> | <b>47</b> |
| Vita Maryah Ardiyani, S.Kep., Ns., M.Kep.....                                                    | 47        |
| A. Pendahuluan.....                                                                              | 47        |
| B. Konsep Triage .....                                                                           | 48        |
| C. Konsep Peran Perawat .....                                                                    | 62        |
| D. Tugas dan Peran Perawat Triage .....                                                          | 70        |
| E. Referensi.....                                                                                | 72        |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                                                      | <b>77</b> |



# CHAPTER 1

## ETIKA KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONDISI KRISIS

Ns. Novia Wulansari, M.Kep., Sp.Kep.MB.

### **A. Pendahuluan/prolog**

---

Gawat darurat merujuk pada situasi medis yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kematian dan kerusakan yang serius pada kesehatan pasien, hal ini merujuk pada kondisi seperti cedera trauma, serangan jantung, stroke, dan keadaan lain yang mengancam jiwa, marx, J.A.et.al, (2019). Sedangkan konsep gawat darurat mengacu pada rangkaian prinsip, prosedur, dan pengetahuan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani situasi medis mendesak yang memerlukan perhatian segera untuk mencegah kematian dan cacat serius. Kejadian tidak terduga bisa saja terjadi saat di dalam klinik maupun rumah sakit yang menyebabkan kondisi kegawatdaruratan dimana tenaga medis baik dokter, perawat, maupun tim kesehatan yang lain dituntut harus melakukan tindakan yang sesegera mungkin untuk menolong pasien.

Peran perawat gawat darurat sangat penting dalam memberikan asuhan gawat darurat kepada pasien dengan

berbagai kasus gawat darurat (Duchscher & Pelukis, 2021). Perawat darurat harus bekerja di lingkungan yang serba cepat dan penuh tekanan di mana mereka harus menilai pasien dengan cepat, merencanakan dan menerapkan intervensi keperawatan darurat, berkomunikasi dengan beberapa profesional kesehatan, dan memastikan perawatan pasien efektif dan efisien (Ghazali et al., 2020; Rubio-Navarro et al., 2019, 2020).

Keperawatan gawat darurat adalah bidang keperawatan yang focus pada penanganan cepat dan komprehensif terhadap pasien dengan kondisi kritis atau keadaan kedaruratan medis yang mengancam jiwa. Tujuannya adalah untuk memberikan perawatan yang tepat dan waktu yang efektif guna meminimalkan kematian dan resiko cacat permanen pada pasien, Emergency Nurse Association. (2018). Perawat memiliki peran penting dalam kondisi gawat darurat, termasuk evaluasi cepat, menyediakan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas, melakukan tindakan resusitasi jika diperlukan, serta memberikan dukungan emosional dan informasi kepada pasien dan keluarganya, Hoyt, K. S. et al. (2019). Konsep dasar gawat darurat adalah serangkaian prinsip dan prosedur yang di gunakan untuk menangani situasi medis yang mengancam jiwa atau memerlukan intervensi segera guna mencegah kerusakan yang lebih lanjut pada pasien, Tintinalli, J.E, et al, 2016.

## **B. Kegawatdaruratan dalam Keperawatan**

---

Perawat yang membantu korban dalam situasi emergency harus menyadari konsekuensi hukum yang dapat terjadi sebagai akibat tindakan yang mereka berikan. Banyak negara-negara yang telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi kesehatan yang menolong korban-korban kecelekaan . Undang-undang ini bervariasi diberbagai Negara, salah satu diantaranya memberlakukan undang-undang ? Good Samaritan? yang berfungsi untuk mengidentifikasi bahasa/istilah hukum orang-orang atau situasi yang memberikan kekebalan tanggung jawab tertentu, banyak diantaranya ditimbulkan oleh adanya undang-undang yang umum.

Perawatan yang dapat dipertanggung jawabkan diberikan oleh perawat pada tempat kecelakaan biasanya dinilai sebagai perawatan yang diberikan oleh perawatannya serupa lainnya dalam kondisi-kondisi umum yang berlaku. Maka, perawatan yang diberikan tidaklah dianggap sama dengan perawatan yang diberikan di ruangan emergency.

Perawat-perawat yang bekerja di emergency suatu rumah sakit harus menyadari implikasi hukum dari perawatan yang diberikan seperti memberikan persetujuan dan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan dalam membantu kondisi mencari bukti-bukti.

Prinsip Etik dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan

### **1. Autonomy**

Perawat yang mengikuti prinsip autonomy akan menghargai hak klien untuk mengambil keputusan

sendiri. Dengan hal ini, berarti perawat menyadari keunikan individu secara holistik.

## **2. Non-maleficence (do no harm)**

Tindakan yang dilakukan perawat tidak menyebabkan bahaya bagi klien. Prinsip ini adalah prinsip dasar sebagian kode etik keperawatan.

## **3. Beneficence (do good)**

Perawat memiliki kewajiban untuk melakukan hal dengan baik, yaitu mengimplementasikan tindakan yang menguntungkan klien dan keluarga. Beneficence itu dimaksudkan untuk menentukan cara terbaik yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan klien. Perawat harus selalu melakukan hal dengan baik, termasuk dalam hal pemberian asuhan keperawatan guna membantu mempercepat proses penyembuhan klien.

## **4. Informed Consent**

Merupakan persetujuan seseorang untuk mengizinkan dilakukannya sesuatu terhadap dirinya. Dalam informed consent berisi pemberitahuan tentang resiko penting yang potensial, keuntungan, dan alternatif yang ada.

## **5. Justice (perlakuan adil)**

Perawat harus selalu berlaku adil kepada semua klien.

## **6. Kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan**

Prinsip mengatakan yang sebenarnya (kejujuran) mengarahkan praktisi untuk menghindari melakukan kebohongan atau menipu klien. Dalam hal ini perawat

harus menginformasikan semua hal yang berkaitan dengan kondisinya.

Kerahasiaan adalah suatu tindakan dari perawat untuk menghindari pembicaraan mengenai kondisi klien dengan siapapun yang tidak terlibat secara langsung dalam perawatan klien, kesetiaan menyatakan bahwa perawat harus memegang janji yang dibuatnya pada klien. Ketika seorang perawat jujur dan memegang janjinya maka seorang pasien akan menaruh kepercayaan pada perawat, dengan hal itu perawat dengan mudah melakukan intervensi.

### **1. Perawat Unit Gawat Darurat**

Adapun konsep dalam asuhan keperawatan gawat darurat yang meliputi yang harus dimiliki oleh perawat di unit gawat darurat antara lain:

#### **a. Penilaian cepat**

Perawat harus mampu melakukan penilaian cepat terhadap kondisi pasien dengan memperhatikan tanda vital, gejala, riwayat medis, dan factor-faktor yang berkaitan. Penilaian ini memungkinkan perawat untuk memprioritaskan intervensi yang diperlukan. Menurut penelitian oleh Berman et al. (2020). Penilaian cepat memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mendesak dan menentukan prioritas tindakan yang diperlukan

#### **b. Prioritas tindakan**

Prioritas tindakan adalah konsep penting dalam asuhan keperawatan gawat darurat, perawat harus mampu memprioritaskan tindakan yang akan

dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dan tingkat urgensi pasien, tindakan yang paling vital dan mendesak harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien, Ferguson, et al. (2018)

c. Kemampuan teknis

Perawat gawat darurat harus memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam melakukan prosedur-prosedur medis darurat seperti pemantauan tanda-tanda vital, penanganan kegawatan jantung, pemindahan pasien, pemberian obat-obatan darurat, stabilisasi pasien dan lain sebagainya. Menurut penelitian oleh Smith et al. (2019), stabilisasi pasien melibatkan tindakan untuk mempertahankan fungsi fisiologis yang vital dan menghindari kerusakan organ yang lebih lanjut.

d. Kemampuan komunikasi

Kemampuan komunikasi yang efektif dengan anggota tim medis lainnya sangat penting dalam asuhan keperawatan gawat darurat. Perawat perlu dapat berkomunikasi dengan jelas dan tepat dalam situasi yang serba cepat dan berpotensi stress

e. Kolaborasi tim

Asuhan keperawatan gawat darurat melibatkan kerja sama yang erat dengan tim medis lainnya seperti dokter, paramedic, dan petugas medis lainnya. Kolaborasi yang baik antar anggota tim dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan

pasien. Penelitian oleh Jones, et al. (2021) menyoroti tentang pentingnya kerjasama antara perawat, dokter, paramedic, dan anggota tim medis lainnya dalam memberikan perawatan yang efektif dan terkoordinasi.

f. Pendekatan holistic

Meskipun focus utama dalam asuhan keperawatan gawat darurat adalah penanganan kondisi akut, perawat juga harus memperhatikan kebutuhan pasien secara keseluruhan, ini juga harus mendengarkan kekhawatiran pasien, memberikan dukungan emosional, dan memastikan bahwa pasien dan keluarganya terlibat dalam proses keperawatan

g. Edukasi pasien

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang kondisi medis, prosedur perawatan, dan tindakan pencegahan yang diperlukan setelah meninggalkan unit gawat darurat. Penerapan konsep dasar ini memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan gawat darurat yang komprehensif, efektif, dan berorientasi kepada pasien.

## **2. Pengambilan keputusan dalam kondisi kritis**

Perawat gawat darurat membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus untuk dapat memecahkan masalah dalam kondisi stres ini (Ghazali et al., 2020). Perawat gawat darurat harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah yang kuat, keterampilan komunikasi, kerja tim yang

sangat baik, pengetahuan tentang standar dan pedoman praktik keperawatan darurat, dan keahlian dalam menggunakan peralatan dan teknologi medis canggih (Ghazali et al., 2020; Rubio-Navarro et al., 2019, 2020). Selain itu, perawat gawat darurat harus memiliki kemampuan untuk memprioritaskan dan melakukan banyak tugas secara efektif sambil tetap tenang di bawah tekanan (Ghazali et al., 2020). Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dapat mempengaruhi kondisi pasien dalam situasi yang mengancam jiwa (Yang et al., 2023).

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan klinis perawat gawat darurat**

Beberapa faktor mempengaruhi pengambilan keputusan klinis oleh perawat gawat darurat ketika merawat pasien sehingga masalah klinis mereka teratasi. Beberapa faktor tersebut adalah:

#### **a. Penampilan Pasien dan Informasi Klinis**

Salah satu literatur menyatakan bahwa perawat dapat membedakan pasien "sakit" dari pasien "tidak sakit" berdasarkan presentasi atau penampilan pada saat kedatangan. Proses Triase dimulai ketika perawat pertama kali melihat pasien (Ouzzani et al., 2016; Serigala et al., 2022). Kebanyakan perawat gawat darurat dapat membedakan masalah "ABC" (jalan napas, pernapasan, atau sirkulasi) saat masuk ke ruang gawat darurat. Kemunculan pasien pada saat kedatangan juga didukung oleh keluhan pasien, lamanya tanda dan gejala, habitus tubuh (perilaku

tubuh pasien), dan lingkungan di unit gawat darurat mempengaruhi perawat dalam mengambil keputusan klinis, terutama terkait tingkat keparahan pasien (Callihan et al., 2023; Hundial, 2020; Soola et al., 2022; Yani dkk., 2023). Selain itu, perawat berusaha menemukan informasi klinis spesifik (CI) apa yang digunakan perawat dan bagaimana kaitannya dengan ketajaman pasien. Benang merah CI yang dikumpulkan termasuk (1) Keluhan Utama, (2) Tanda Vital termasuk rasa sakit (3) Gejala dan (4) indikasi medis / riwayat medis. Belajar oleh (Tracy et al., 2020) Menunjukkan bahwa riwayat medis adalah salah satu bagian terpenting dari informasi yang dikumpulkan serta salah satu yang paling dibutuhkan. Informasi klinis berusaha untuk menentukan apa isyarat triase berdasarkan bervariasi berdasarkan jenis kelamin pasien atau informasi demografis dan gejala (gejala klasik), Tanda-tanda vital, beberapa penelitian menjelaskan perawat berpengalaman dilaporkan menggunakan gejala selain keluhan utama dan presentasi klinis pasien untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Alba, 2018).

b. Pengalaman Klinis dan Intuisi

Perawat menerapkan kedua aspek intuisi klinis dan pengetahuan subjektif mereka, diikuti oleh pengetahuan teoritis dan praktis bahwa perawat memutuskan untuk menerapkan pada situasi tertentu berdasarkan kebutuhan pasien (misalnya pasien yang tidak stabil cenderung menjadi prioritas untuk

perawatan karena perawat tahu konsekuensi teoritis dari menunda perawatan dan telah mengalaminya selama praktik di UGD). Pengalaman Perawat sangat signifikan terhadap akurasi ketika triase dan menggunakan intuisi pengambilan keputusan. Sebagian besar terkait perasaan mereka bahwa pengetahuan dan pengalaman keperawatan diperlukan untuk membuat keputusan. Berfokus pada pengamatan interaksi triase dan temuan pada presentasi pasien (keluhan, durasi gejala, dan habitus tubuh), volume pasien, dan lingkungan perawatan (pimpinan unit, komunikasi dengan pasien dan penyedia, dan lamanya waktu dalam triase). Hasilnya ditafsirkan untuk menunjukkan bahwa ketajaman ditetapkan berdasarkan faktor perawat individu versus protokol institusional atau skala penilaian. Faktor perawat individu termasuk penggunaan intuisi, pengalaman gawat darurat (Abu Arra et al., 2023; Rubio-Navarro et al., 2019; Serigala, 2010; Serigala et al., 2022).

c. Lembaga dan Protokol yang Berlaku

Institusi perawatan kesehatan juga mempengaruhi pengambilan keputusan klinis perawat ini melalui sumber daya yang diberikan kepada perawat (misalnya staf perawat lain yang dapat membantu mereka) dan protokol yang mengatur praktik keperawatan (misalnya kerangka waktu pemberian obat dalam protokol sepsis) sehingga ini berkontribusi pada peran

perawat dalam membuat keputusan klinis dalam layanan darurat (Rubio-Navarro et al., 2019). Hal lain yang termasuk dalam hal ini adalah hierarki posisi. Akuntabilitas hierarkis posisional adalah penyebaran akuntabilitas yang terkait dengan keputusan melalui struktur hierarkis, yang melibatkan karyawan dengan pengaruh lebih besar daripada perawat tetapi tanpa mempengaruhi institusi perawatan kesehatan itu sendiri. Perawat yang lebih senior dan memiliki pelatihan dan pengalaman dalam resolusi konflik memungkinkan mereka untuk menenangkan pasien dan meminimalkan persepsi mereka tentang pengalaman negatif, sehingga menghindari inisiasi proses hukum oleh pasien (misalnya meyakinkan pasien bahwa keterlambatan dalam pemberian obat mereka tidak dapat dihindari karena beban kerja). kelebihan klinis perawat) (Rubio-Navarro et al., 2019; Yang et al., 2023).

d. Beban kerja, kebebasan kerja atau lingkungan Perawatan

Beban kerja perawat telah dikaitkan dengan hasil pasien yang negatif, seringkali didasarkan pada pengabaian perawatan yang diberikan kepada pasien. Dalam 1 artikel dikatakan bahwa ada indikasi bahwa beban kerja yang berat dan besar di unit gawat darurat (IGD) yang khas, menyebabkan perawat cenderung menjadi "mesin", daripada menerapkan penilaian klinis yang baik, yang menyebabkan hilangnya langkah-

langkah penting dalam perawatan pasien (Serigala, 2010). Seorang perawat darurat yang merasa kelebihan beban di tempat kerja lebih cenderung memiliki kesalahan dalam perawatan pasien karena perhatian dialihkan untuk menyelesaikan tugas daripada menerapkan penilaian klinis dan penalaran darurat. Fokus pada menyelesaikan tugas selama multitasking adalah risiko bagi keselamatan pasien (Wolf, 2010; Serigala et al., 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketajaman ditetapkan berdasarkan faktor lingkungan dari unit / fasilitas tertentu. merapikan hubungan antara basis pengetahuan, aplikasi kritis, agensi moral, budaya unit, hubungan perawat, dan lingkungan kelembagaan / perawatan kesehatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan triase (Soola et al., 2022). Studi ini juga menunjukkan hubungan lingkungan perawatan yang mendorong kerja tim, peningkatan kontrol atas praktik, komunikasi yang baik tentang pasien, dan peningkatan kepemimpinan dan otonomi dengan peningkatan akurasi dalam triase (Ghazali et al., 2020; Ouzzani et al., 2016). Selain itu, ada juga hubungan positif antara akurasi dan tingkat pendidikan dan hubungan negatif untuk lembaga dengan kompleksitas yang lebih rendah.

e. Pendidikan Perawat

Pendidikan perawat berperan penting dalam pengambilan keputusan klinis bagi perawat di IGD. Hasil analisis regresi linier dalam satu artikel

menemukan bahwa pendidikan keperawatan berkontribusi pada variasi dalam pengambilan keputusan klinis untuk perawat dalam pengaturan darurat. Pendidikan juga mempengaruhi persepsi perawat gawat darurat dalam membuat keputusan klinis (Abu Arra dkk., 2023). pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan perawat triase. Meningkatkan kesadaran perawat dari berbagai tingkat pengalaman dan pendidikan terhadap tren kesalahan identifikasi, serta memberikan umpan balik yang dipersonalisasi, dapat membantu mengurangi kesalahan identifikasi dan proses pengambilan keputusan di Departemen darurat (Soola et al., 2022). Studi lain menunjukkan bahwa kualitas perawatan tidak terpengaruh secara signifikan oleh pendidikan perawat (Audet et al., 2018), dan pengalaman perawat, dengan sendirinya, mungkin tidak meningkatkan pengambilan keputusan triase, melainkan bahwa peningkatan hasil dari kemahiran dalam proses pengambilan keputusan.

f. Pendidikan dan pelatihan

Sebuah studi melaporkan bahwa pendidikan dan pelatihan triase di departemen darurat penting untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan triase staf ED. Hal ini ditunjukkan setelah paparan pelatihan triase, keterampilan dan akurasi dalam pengambilan keputusan triase meningkat, mengungkapkan bahwa pelatihan triase terstruktur

secara signifikan efektif dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan klinis, terutama dalam triase. Pendidikan dan pelatihan yang kuat tentang keluhan dan penilaian pasien setibanya di UGD meningkatkan pengetahuan dan pemikiran kritis perawat, dan, dengan demikian, meningkatkan keterampilan dan akurasi mereka dalam pengambilan keputusan klinis, terutama triase (Rubio-Navarro et al., 2020).

g. Kemampuan Berpikir Kritis Perawat

Berpikir kritis dianggap sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis yang aman, efektif, etis, dan dianggap penting dalam praktik keperawatan profesional (Callihan et al., 2023; Rababa et al., 2022; Serigala et al., 2022). Seorang perawat darurat disebut kompeten dan analitis jika dia dapat dengan mudah mengenali penyimpangan dari nilai normal. Dimana perawat yang ahli dapat merespon secara otomatis berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman intuitif.

## C. Referensi

---

- Abu Arra, A. Y., Ayed, A., Toqan, D., Albashtawy, M., Salameh, B., Sarhan, A. L., & Batran, A. (2023). The Factors Influencing Nurses' Clinical Decision-Making in Emergency Department. *Inquiry (United States)*, 60. <https://doi.org/10.1177/00469580231152080>

- Alba, B. (2018). Factors that impact on emergency nurses' ethical decision-making ability. *Nursing Ethics*, 25(7), 855–866.  
<https://doi.org/10.1177/0969733016674769>
- Audet, L. A., Bourgault, P., & Rochefort, C. M. (2018). Associations between nurse education and experience and the risk of mortality and adverse events in acute care hospitals: A systematic review of observational studies. *International Journal of Nursing Studies*, 80(January), 128–146.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.01.007>
- Callihan, M. L., Wolf, L., Cole, H., Robinson, S., Stokley, H., Rice, M., Eyer, J. C., Tice, J., Mohabbat, S., & Rogers, S. (2023). Determining Clinical Judgment Among Emergency Nurses During a Complex Simulation. *Journal of Emergency Nursing*, 49(2), 222–235.  
<https://doi.org/10.1016/j.jen.2022.11.010>
- Duchscher, E. J., & Painter, S. (2021). Proceed With Caution: Integrating Newly Graduated Nurses Into an Emergency Department. *Adv Emerg Nurs J*, 43(1), 53–70.
- Ghazali, S. A., Abdullah, K. L., Moy, F. M., Ahmad, R., & Hussin, E. O. D. (2020). The impact of adult trauma triage training on decision-making skills and accuracy of triage decision at emergency departments in Malaysia: A randomized control trial. *International Emergency Nursing*, 51(May), 100889.  
<https://doi.org/10.1016/j.ienj.2020.100889>

- Hundial, H. (2020). The Safe Care Framework™: A practical tool for critical thinking. *Nurse Education in Practice*, 48, 102852.  
<https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102852>
- Khairina, I., Malini, H., & Huriani, E. (2020). Pengetahuan Dan Keterampilan Perawat Dalam Pengambilan Keputusan Klinis Triase. *Link*, 16(1), 1–5.  
<https://doi.org/10.31983/link.v16i1.5449>
- Kindie Abate, H., Birhanu, Y., & Hailu Gebrie, M. (2022). Clinical decision making approaches and associated factors among nurses working in a tertiary teaching hospital. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 17(May), 100432.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijans.2022.100432>
- Kraus, C. K., & Marco, C. A. (2016). Shared decision making in the ED: ethical considerations. *American Journal of Emergency Medicine*, 34(8), 1668–1672.  
<https://doi.org/10.1016/j.ajem.2016.05.058>
- Mitchell, M. A. (2015). Assessing Patient Decision-Making Capacity: It's About the Thought Process. *Journal of Emergency Nursing*, 41(4), 307–312.  
<https://doi.org/10.1016/j.jen.2014.10.014>
- Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan-a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, 5(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>

- Pasaribu, Y. (2020). *Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Klinis Perawat di Ruang IGD*. Ennis 1996. <https://osf.io/preprints/xts39/>
- Peters, M. D. J., Godfrey, C. M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D., & Soares, C. B. (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews. *International Journal of Evidence- Based Healthcare*, 13(3), 141–146. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000050>
- Rababa, M., Bani-Hamad, D., & Hayajneh, A. (2022). The effectiveness of branching simulations in improving nurses' knowledge, attitudes, practice, and decision-making related to sepsis assessment and management. *Nursing Education Today*, 110(3). <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105270>
- Rahayu, C. D., & Mulyani, S. (2020). Pengambilan Keputusan Klinis Perawat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1–11.
- Rubio-Navarro, A., Garcia-Capilla, D. J., Torralba-Madrid, M. J., & Rutty, J. (2019). Ethical, legal and professional accountability in emergency nursing practice: An ethnographic observational study. *International Emergency Nursing*, 46(November 2018), 100777. <https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.05.003>
- Rubio-Navarro, A., García-Capilla, D. J., Torralba-Madrid, M. J., & Rutty, J. (2020). Decision- making in an emergency department: A nursing accountability model. *Nursing Ethics*, 27(2), 567–586. <https://doi.org/10.1177/0969733019851542>

- Soola, A. H., Mehri, S., & Azizpour, I. (2022). Evaluation of the factors affecting triage decision-making among emergency department nurses and emergency medical technicians in Iran: a study based on Benner's theory. *BMC Emergency Medicine*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12873-022-00729-y>
- Stanfield, L. M. (2015). Clinical Decision Making in Triage: An Integrative Review. *Journal of Emergency Nursing*, 41(5), 396–403. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2015.02.003>
- Tracy, M. F., Oerther, S., Arslanian-Engoren, C., Girouard, S., Minarik, P., Patrician, P., Vollman, K., Sanders, N., McCausland, M., Antai-Otong, D., & Talsma, A. N. (2020). Improving the care and health of populations through optimal use of clinical nurse specialists. *Nursing Outlook*, 68(4), 523–527. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2020.06.004>
- Wolf, L., Perhats, C., Delao, A., Frisch, S., Moon, M., & Strout, T. (2022). Role and Training of Emergency Department Charge Nurses: A Mixed Methods Analysis of Processes, Needs, and Expectations. *Emergency Nurses Association*, 48(4), 390–405. doi: 10.1016/j.jen.2022.03.009
- Yang, J., Wan, X., Yu, P., & Li, X. (2023). Factors affecting the triage decision-making ability of emergency nurses in Northern China: A multi-center descriptive survey.

*International Emergency Nursing*, 67(February), 101264. <https://doi.org/10.1016/j.ienj.2023.101264>

Yani, A., Hamid, S., Ariesta, Y., Farosyah, A., Wakhid, A., Falahaini, A., & Yulianingsih, Y. (2023). *Nurse Education in Practice Sustainable disaster risk reduction training model for nurses : A descriptive qualitative approach*. 69(November 2022), 0–7.



# CHAPTER 2

## KERJA TIM DAN KOLABORASI ANTAR PROFESI DALAM PENANANGANAN GAWAT DARURAT

Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep.

### A. Pendahuluan

---

Menurut (Moussa et al., 2022), kerja tim digunakan secara sinonim dengan kolaborasi dan kemitraan akan tetapi dapat ditarik kesimpulan sebagai bentuk definisi yang berbeda dalam penelitian bencana. mendefinisikan kerja tim sebagai hasil yang dapat dinegosiasikan dalam membawa anggota organisasi untuk bertindak, bernalar, berperilaku, dan bekerja dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi bersama (kolaborasi). Lebih lanjut, menurut (Finn et al., 2010), kerja tim merupakan tindakan yang melibatkan penyatuan berbagai kelompok dalam suatu organisasi sebagai identitas bersama dan memaksimalkan masukan mereka dalam mencapai tujuan manajemen. Namun, dalam praktiknya, tim mungkin dapat mengalami kesulitan berkolaborasi (Diefenbach & Sillince, 2011), karena perbedaan budaya dan manifestasi faktor-faktor seperti birokrasi yang komprehensif, hierarki keputusan, bahasa, tujuan dan sasaran, harapan dalam peran dan tanggung jawab, dan praktik komunikasi yang mungkin berasal dari persepsi yang

berbeda tentang apa kolaborasi dan apa yang diperlukan dalam kolaborasi (Grossman et al., 2021).

(*World Health Organization*, 2022 ) menekankan bahwa kerja tim adalah syarat utama dalam semua fase manajemen darurat.

Kolaborasi yang kurang baik selama keadaan darurat merupakan sebuah tantangan signifikan yang memengaruhi pekerja perawatan kesehatan (HCW) secara global (Jamshidi et al., 2019). Misalnya, HCW Amerika, seperti di negara-negara Arab, mengalami kesulitan bekerja sama untuk meminimalkan komplikasi bencana (Schmutz et al., 2019); (Alandijany et al., 2020), yang menunjukkan perlunya menentukan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di sektor kesehatan untuk mendorong kerja tim dan kolaborasi dalam manajemen DPHE (Gooding et al., 2022). Merupakan hal yang umum di negara-negara seperti Arab Saudi (Robertson et al., 2002) untuk merekrut staf perawatan kesehatan dari berbagai negara, dan campuran preferensi budaya dapat menjadi hambatan untuk komunikasi (Zakarya Ali Qasem Ghalib, 2019).

Selain itu, negara-negara Arab diketahui memiliki organisasi yang sangat hierarkis (Hofstede 1984 ; (Shackleton & Ali, 1990) ; (Robertson et al., 2002) ; Alamri et al. 2014 ) dan jarak kekuasaan (PD), yaitu sejauh mana anggota organisasi dan lembaga yang kurang berkuasa menerima dan berharap bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata (Hofstede 1991 ; (Grossman et al., 2021)). Hirarki organisasi

dan jarak kekuasaan dapat mencegah pembentukan tim dengan menciptakan tradisi bersosialisasi yang menyita waktu (Zakarya Ali Qasem Ghalib, 2019), yang menurut (Aldulaimi, 2019), mencegah inovasi dan penanganan perubahan karena tradisi suku dan klan yang tidak aktif. Menyelamatkan muka adalah hal yang umum dan dapat menghalangi kekhasan (Yaseen, 2010). Ada juga preferensi yang kuat untuk menjaga keharmonisan kelompok dan menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada pemimpin yang lebih tua daripada peserta yang lebih muda dan lebih kompeten (Mostafa, 2003). Lebih jauh lagi, perempuan sering dianggap kurang cakap dibandingkan laki-laki untuk memimpin organisasi pada posisi tinggi (Mostafa, 2003); (Yaseen, 2010) ; (Zakarya Ali Qasem Ghalib, 2019). Dengan demikian, berdasarkan penelitian dan teori terkini, ada alasan untuk menduga bahwa keberagaman budaya dan nasional dapat memengaruhi cara seseorang mengonseptualisasikan dan mendekati kolaborasi dan bahwa pengaruh ini dapat muncul secara berbeda bagi para kolaborator, seperti di antara karyawan di rumah sakit Arab Saudi, yang menghambat efektivitas kerja tim (Alahmadi, 2010).

Tim yaitu kelompok orang yang mempunyai latar belakang keahlian yang berbeda-beda dan bekerja pada bidang pekerjaan tertentu ( Abi Sujak, 1990). Dapat diartikan lain dua atau lebih individu yang berinteraksi serta saling tergantung dan berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu ( Sentanoe Kartonegoro,1994)

## **B. Manfaat Dan Tujuan Bekerja Dalam Tim**

---

Bekerja dalam tim memiliki banyak fungsi dan manfaat. Fungsi bekerja dalam tim antara lain dapat mengubah sikap, perilaku, dan nilai-nilai pribadi, serta dapat turut serta dalam mendisiplinkan anggota lainnya. Selain itu tim dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, merundingkan, dan bernegosiasi (*bargaining*). Anggota tim dengan latar belakang yang berbeda-beda mungkin saja membawa perspektif atau pengaruh positif terhadap proses pengambilan keputusan.

## **C. Prinsip-Prinsip Kerja Tim dan Kolaborasi Antar Profesi**

---

### **1. Prinsip Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan**

- a. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak padalandsan yang sama, kesediaan untuk berkorban
- b. Kesetaraan dapat dilihat langsung dengan adanya kesamaan dalam hal derajat, posisi, maupun peran

untuk suksesnya kerjasama. Dengan kesetaraan maka diharapkan kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kerjasama yang telah dirintis tanpa ada tekanan dari pihak lain. Dengan demikian, prestasi kerjasama yang dicapai merupakan sinergi atau prestasi bersama.

- c. Kerjasama dilakukan untuk memberikan manfaat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama hanya salah satu pihak yang diuntungkan maka hal tersebut bukanlah merupakan kerjasama yang baik namun lebih tepat diartikan dengan pemanfaatan yang bisa jadi disebabkan karena adanya keterbatasan salah satu pihak. Dengan adanya kesadaran bahwa kerjasama harus saling menguntungkan maka hal yang harus diperhatikan rupanya bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan keuntungan yang seimbang. Akan menyimpang, dari prinsip dasar apabila kerjasama hanya menguntungkan salah satu pihak atau terjadi ketidakseimbangan dalam hal mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan antar institusi.

- d. Saling menguntungkan

Dengan adanya kesadaran bahwa kerjasama harus saling menguntungkan maka hal yang harus diperhatikan rupanya bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan keuntungan yang seimbang. Akan menyimpang, dari prinsip dasar

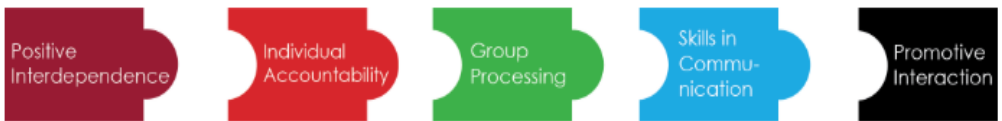
apabila kerjasama hanya menguntungkan salah satu pihak atau terjadi ketidakseimbangan dalam hal mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan antar institusi

## **2. Menggunakan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan**

Dalam melakukan kerja tim hendaknya dapat dilakukan musyawarah saat akan mengambil sebuah keputusan sebelum melakukan sesuatu untuk dapat disepakati secara bersama

## **3. Saling menghargai keberadaan masing-masing Lembaga**

Saling menghargai pada Lembaga masing-masing agar keputusan-keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.



**Gambar 2.1 Five Basic Elements of Effective Teams**

## **D. Langkah dalam Membangun Kerjasama Tim**

---

Beberapa Langkah yang dapat dilakukan dalam membangun kerja Tim adalah (Lasmi et al., 2021)

1. Membangun Kepercayaan Dan Saling Menghormati  
Didalam sebuah tim didirikan berdasarkan kepercayaan antar sesama yang kuat. Disamping itu setiap anggota tim akan lebih baik lagi jika saling menghormati posisi masing-masing. Dengan kuatnya rasa saling percaya dan

saling menghormati maka akan mempermudah bekerja sama dengan sesama dan pemimpin dapat mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh anggota tim dengan baik.

2. Mengatur Ekspektasi Bersama Tentunya setiap orang mempunyai semangat pencapaian karir yang berbeda, maka akan lebih baik menyelaraskan ekspektasi dalam tim. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang mereka harapkan dari setiap kegiatan bekerjasama dalam tim. Tentunya tak hanya mengatur ekspektasi saja, tetapi juga berusaha secara bersama-sama untuk memenuhinya.
3. Pemimpin Tim Dapat Memfasilitasi Komunikasi Diantara Anggota Tim Hal ini penting untuk menciptakan atmosfer komunikasi yang terbuka, jujur dan saling menghormati. Setiap anggota tim berhak untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk pemikiran, opini, bahkan hingga solusi yang menjawab permasalahan yang ditemui kelompok. Mereka juga terbuka untuk mendengar dan mendengarkan untuk memahami masing-masing buah pikiran. Selain itu, suasana keterbukaan dimana anggota tim juga dapat mengajukan sejumlah pertanyaan untuk klarifikasi ide-ide yang dilemparkan. Hal ini justru lebih baik dibandingkan sikap mematahkan setiap ide yang muncul ke permukaan.
4. Menanamkan Sikap Saling Memiliki Dalam Kelompok (Sense Of Belonging) Anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan grup akan memiliki komitmen akan

tindakan dan aksi tim. Sikap saling memiliki akan semakin mendalam saat anggota tim menghabiskan waktu bersama mengembangkan norma atau panduan yang berlaku pada tim secara bersama. Selain itu, pemimpin tim sebaiknya mengikut sertakan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan sebagai realisasi dari kerja sama tim bersama.

5. Melihat Sisi Positif Dari Perbedaan Pendapat Perbedaan mendasar dari bekerja sama dengan bekerja sendiri adalah jumlah kepala yang menuangkan ide ke dalam pekerjaan. Perbedaan pendapat merupakan dua sisi pada koin, dapat dipandang sebagai hambatan atau sebagai manfaat. Sebaiknya kita memasang kaca mata positif dalam memandang suatu fenomena dalam berinteraksi dengan sejumlah orang, hal ini berarti bahwa ada sudut pandang lain yang bisa dianggap sebagai kesempatan yang bisa ditelusuri dan digunakan untuk kepentingan badan.
6. Pengkajian Performa Tim Dan Umpan Balik Setelah selesai kerja sama tim, jangan lupa untuk mengkaji ulang performa ekspektasi dan tujuan tim. Juga jangan lupa meminta umpan balik dari rekan-rekan tim Anda. Hal ini perlu untuk mengukur apakah pencapaian kinerja tim Anda. Nah, dari sinilah Anda bisa melihat ruang untuk memperbaiki kinerja untuk proyek tim selanjutnya. Disamping itu, setelah melihat kinerja tim, Anda bisa memberikan reward (hadiah) dan insentif seperlunya agar memotivasi seluruh anggota tim untuk kinerja yang lebih

baik di masa depan dan sebagai bukti penghargaan atas kerja sama.

## **E. Tahapan Perkembangan Tim**

---

Terdapat beberapa tahapan perkembangan kerja tim diantaranya adalah sebagai berikut (Arsyadana, 2019):

### **1. Tahap 1 Pembentukan (*Forming*)**

Tahap pertama dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian. Mengenai struktur, maksud dan tujuan, dan kepemimpinan kelompok. Pada tahap ini dicirikan oleh banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota melakukan uji coba untuk menemukan tipe-tipe perilaku apakah yang dapat Dasar-Dasar Perilaku Kelompok Dan Memahami Tim Kerja diterima baik. Tahap ini selesai ketika para anggota telah mulai berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok

### **2. Tahap 2 (Perjuangan (*Storming*))**

tahap kedua dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh konflik didalam kelompok, artinya para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan adanya kendala-kendala yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualitas. Tahap keributan adalah tahap komplik di dalam kelompok (intragrup).

### **3. Tahap 3 Pengaturan (*Norming*)**

tahap ketiga dalam perkembangan kelompok, dicirikan oleh hubungan akrab dan kekohesifan (ke saling

tertarikan) Tahap penormaan adalah tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif (saling tarik). Sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap ini selesai jika telah terbentuk struktur kelompok yang kokoh dan menyesuaikan harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar

#### **4. Tahap 4 Pelaksanaan (*Performing*)**

Tahap keempat dalam perkembangan kelompok, dimana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik.

#### **5. Tahap 5 Penyelesaian (*Adjourning*)**

Tahap terakhir dalam perkembangan kelompok dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan kegiatan, bukan melaksanakan tugas.

### **F. Kolaborasi Antar Profesi dalam Penanganan Kegawatdaruratan**

---

#### **1. Konsep Kolaborasi**

Menurut *World Health Organization* (WHO), Kolaborasi antar profesi atau disebut juga dengan interprofesi yaitu upaya terkoordinasi dari beberapa profesional kesehatan dengan latar belakang yang beragam untuk memberikan pelayanan secara lengkap dan berkualitas kepada pasien, keluarga, kelompok, dan komunitas.

*Interprofessional Collaboration* atau Kolaborasi Interprofesi (IPC) adalah metode yang digunakan dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan dengan cara membina kemitraan produktif antara pendidik, penyedia layanan kesehatan, anggota masyarakat, dan penerima layanan kesehatan (Putriana & Saragih, 2020). Pelayanan kegawatdaruratan merupakan salah satu unit di Rumah Sakit yang membutuhkan interaksi dan mobilitas yang tinggi dari berbagai profesional kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada pasien (Jayawisastra, 2022).

Kolaborasi multidisiplin atau dinamakan interprofesional kolaborasi memiliki definisi ketika beberapa petugas kesehatan dari latar belakang profesional kesehatan yang berbeda memberikan layanan kesehatan yang komprehensif untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Cohen Konrad et al., 2019). Perawatan berbasis tim interprofesional merupakan faktor penting untuk melengkapi keterampilan dan saling mendukung dalam pemberian perawatan berpusat pada pasien (DeFeo, 2021).

## **2. Manfaat Kolaborasi Antar Profesi**

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam penelitian (Patima, 2021), mengatakan bahwa dengan kolaborasi interprofesi akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan keluarga, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kerjasama yang baik meningkatkan perawatan dan koordinasi pelayanan, terutama perawatan kronis dan keselamatan pasien. Tindakan kolektif dalam industri layanan kesehatan mempunyai efek multiplikatif

terhadap keselamatan pasien, lingkungan perawatan, tingkat komplikasi dan kesalahan, lama rawat inap, pergantian staf, dan angka kematian. Hal ini juga mengurangi konflik antar penyedia layanan Kesehatan.

### **3. Kolaborasi dan Kerja Tim**

Kerja tim atau *teamwork* merupakan seperangkat nilai yang mendorong perilaku seperti mendengarkan dan konstruktif menanggapi sudut pandang diungkapkan oleh orang lain, memberi orang lain manfaat dari keraguan, memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya, dan mengakui kepentingan dan prestasi orang lain (Murdoch et al., 2018)

Penelitian diuniversitas Aston di Inggris menjelaskan tiga kondisi yang diperlukan untuk *teamwork*:

- a. Memiliki tujuan yang jelas yang diketahui semua anggota
- b. Anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Ada pertemuan rutin untuk meninjau efektivitas tim dan mendiskusikan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan (Jill Thistlethwaite, 2012).

Kerjasama jugmencerminkan proses koordinasi pekerjaan agar tujuan atau target yang telah ditentukan tercapai (Murdoch et al., 2018) Hal yang diperlukan dalam teamwork perawatan kesehatan (Jill Thistlethwaite, 2012), Jackson and Moran, 2013) yaitu:

- a. Menyetujui aturan-aturan dasar dan proses untuk bekerja sama,
- b. Pemahaman tentang nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan anggota tim, partisipasi aktif oleh semua anggota,
- c. Upaya menyingkirkan stereotip dan hambatan,
- d. Waktu yang 20 teratur untuk mengembangkan kerjasama tim bekerja jauh dari praktek,
- e. Komunikasi yang baik,
- f. Pemahaman masing-masing peran,
- g. Pertemuan tim yang efektif,
- h. Anggota tim menghargai dan menghormati satu sama lain,
- i. Mempertahankan hubungan professional

Konsep "*interprofessionality*," yang diciptakan oleh D'Amour sebagai respon terhadap praktik perawatan kesehatan yang terfragmentasi, didefinisikan sebagai "pengembangan praktik kohesif antara profesional dari berbagai disiplin ilmu. Ini adalah proses dimana tenaga kesehatan merefleksikan dan mengembangkan cara-cara berlatih yang memberikan jawaban terpadu dan kohesif terhadap kebutuhan pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat. *Interprofessionality* dibedakan dari multidisiplin, mengacu pada suatu proses di mana beberapa profesi bekerja secara bersama-sama, baik secara independen maupun parallel (Bertha Margareth, 2023).

Perlu dipahami bahwa konsep "kolaborasi," diidentifikasi sebagai hal penting untuk memberikan

jaminan layanan kesehatan berkualitas. Kolaborasi digambarkan sebagai penyampaian berbagai gagasan serta melakukan tindakan secara bersama-sama berorientasi pada tujuan bersama, dengan penuh semangat serta mengedepankan sikap saling percaya. Kolaborasi interprofessional adalah kesepakatan yang antara para tenaga kesehatan saling menghargai keahlian dan kontribusi yang diberikan oleh berbagai tenaga kesehatan kepada pasien dan akan sangat efektif bila terjalin komunikasi yang baik untuk menyampaikan pendapat di antara anggota tim. Dalam tinjauan literatur pada praktek kolaboratif, teridentifikasi empat konsep yang berhubungan dengan kolaborasi yaitu: berbagi, kemitraan, saling ketergantungan, dan kepemimpinan (Bertha Margareth, 2023). Definisi tim adalah sebagai "sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama serta dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan tim bertujuan agar anggota tim melaksanakan tugasnya dengan baik, anggota memiliki kontribusi dan peran yang setara, dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Elemen-elemen kunci dari kerja tim (Holland, Gaston and Gomes, 2017) (Wartini, 2016) yaitu:

- a. Anggota yang memiliki produk kerja bersama
- b. Tugas-tugas yang saling bergantung
- c. Tanggung jawab bersama
- d. Komitmen

Manajemen konflik Keberhasilan kerja dari dalam tim dapat terjadi apabila terjadi kolaborasi yang baik antar sesama anggota. Menciptakan lingkungan kondusif

didalam menyelesaikan tugas dengan mengedepankan aspek kolaborasi. Kolaborasi terjadi apabila ada sinergi baik yang diciptakan oleh orang-orang dalam tim. Kolaborasi membutuhkan dua elemen kunci, yaitu:

- a. Konstruksi tindakan kolektif yang membahas kompleksitas kebutuhan klien.
- b. Menciptakan kondisi tim yang menyatukan pendapat setiap tenaga kesehatan di mana setiap anggota dapat saling menghormati dan membina hubungan saling percaya dengan baik.

#### **4. Dinamika Kolaborasi Dalam Penanganan Kegawatdaruratan**

Dinamika kolaborasi penanganan kegawatdaruratan bencana dapat diukur menggunakan tiga indikator yaitu, penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Ketiga indikator dari dinamika kolaborasi merupakan pondasi awal yang menentukan persamaan persepsi yang memulai proses kolaborasi penanganan kegawatdaruratan.

#### **5. Dampak serta Adaptasi dalam Proses Kolaborasi Dalam Penanganan Kegawatdaruratan**

Proses kolaborasi penanganan kegawatdaruratan tentunya memiliki dampak terkait kegiatan dalam proses penanganan kegawatdaruratan bencana yang dilakukan para aktor dalam kolaborasi. Dampak yang terjadi dalam proses kolaborasi dalam menghadapi keadaan gawat darurat bencana dapat diukur melalui dampak yang

diharapkan, dampak yang tidak diharapkan, dampak tidak terduga dan juga umpan balik para aktor.

Dampak yang tidak diharapkan atau hambatan yang diperoleh dalam kolaborasi penanganan kegawatdaruratan bencana ialah dalam situasi bencana akses ke lokasi yang terkena dampak bencana menjadi sulit dikarenakan jalan yang rusak, infrastruktur yang hancur dan juga cuaca yang buruk dan juga masyarakat masih belum mampu mengambil langkah yang tepat saat terjadi keadaan darurat bencana dan menganggap remeh akan risiko bencana yang terjadi. Kendala tersebut dapat menghambat kemampuan aktor dalam merespons dengan cepat terhadap kejadian bencana.

Dampak tidak terduga dalam proses kolaborasi dalam melakukan evakuasi ataupun penyelamatan terhadap korban yaitu tuntutan psikologi anggota sering menghadapi tekanan yang tinggi saat menangani bencana. Proses kolaborasi yang dilakukan yang melibatkan masyarakat sebagai aktor memperoleh pertukaran ide dengan instansi terkait dalam keadaan darurat bencana dan juga masyarakat secara tidak langsung mendapatkan berbagai cara penanganan dalam keadaan darurat bencana yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam menangani kegawatdaruratan bencana. Dengan keterlibatan masyarakat maka hal tersebut dapat mendorong inovasi dalam penanganan bencana dan memungkinkan pembelajaran dari berbagai cara penanganan bencana yang berbeda-beda.

Dampak tidak terduga yang menguntungkan tentunya menjadi manfaat yang signifikan dalam

penanggulangan bencana. Selain itu, dampak tidak terduga yang tidak menguntungkan perlu dijadikan bahan pembelajaran yang perlu dikelola dengan baik agar menjadi upaya penanganan kegawatdaruratan bencana tetap efektif dan berkelanjutan

## **6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Antar Profesi**

Menurut (Morato et al., 2021), menyatakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi interprofesi yaitu:

### **a. Faktor Eksternal**

- 1) Faktor pertimbangan dan interpersonal Komponen ini dikaitkan dengan pandangan dan karakter seseorang dalam mengambil keputusan dan menjalankan kekuasaan (Syaifullah, 2008)
- 2) Faktor organisasional dan institusional Aspek ini dikaitkan dengan keterampilan dasar individu, yang berdampak pada proses organisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi dedikasi terhadap pekerjaan seseorang (Morato et al., 2021)

### **b. Faktor Internal**

- 1) Faktor perilaku Perilaku merupakan sikap seseorang terhadap suatu tindakan (Syaifullah, 2008).
- 2) Faktor intrapersonal Kemampuan melihat dan memahami pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain dikenal dengan kesadaran intrapersonal. Konvensi sosial, tekanan teman sebaya, dan teladan yang diberikan oleh keluarga, teman, dan

profesional medis adalah contoh pengaruh intrapersonal (Syaifullah, 2008).

- 3) Faktor Intelektual Menurut David (2015, dalam (Syaifullah, 2008)), Seorang intelektual adalah seseorang yang dapat berpikir, menganalisis, atau memahami dengan cukup baik untuk mengenali dan menghargai sudut pandang dan sudut pandang unik orang lain.

## **7. Dampak Terlaksananya Kolaborasi Antar Profesi**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ita et al., 2021), menyatakan ada beberapa dampak yang terjadi apabila kolaborasi interprofesi terlaksana, yaitu:

- a. Kolaborasi interprofesi dapat memberikan hasil yang baik bagi keselamatan pasien yang berada di Rumah Sakit karena dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik maka tingkat keselamatan pasien juga akan meningkat.
- b. Dengan terjalinnya kerja sama atau kolaborasi antar tenaga Kesehatan dapat meningkatkan penilaian pasien dalam pelayanan yang telah diberikan. Pasien akan menilai puas dengan pelayanan yang diberikan jika melihat antar tenaga Kesehatan terutama dokter dan perawat berhasil membangun kemitraan yang baik
- c. Semakin baik pelaksanaan kolaborasi interprofesi yang dilakukan maka semakin meningkat pula kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit.

## **8. Dampak Terlaksananya Kolaborasi Antar Profesi dalam Kegawatdaruratan**

Kolaborasi antar profesi dalam penanganan kegawatdaruratan memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi pasien, tenaga medis, maupun sistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utamanya:

a. Meningkatkan Keselamatan dan Kesuksesan Perawatan Pasien

- 1) Dengan koordinasi yang baik, pasien menerima penanganan yang lebih cepat dan tepat.
- 2) Meminimalisir risiko kesalahan medis akibat miskomunikasi atau tindakan yang tidak terkoordinasi

b. Efisiensi dalam Pengambilan Keputusan

- 1) Kolaborasi yang baik memungkinkan keputusan cepat berbasis informasi yang akurat dari berbagai tenaga medis.
- 2) Setiap profesi memberikan perspektif berbeda yang dapat memperkaya analisis situasi pasien.

c. Peningkatan Kinerja dan Kepuasan Tenaga Medis

- 1) Beban kerja terbagi secara efektif, mengurangi stres dan kelelahan tenaga medis.
- 2) Lingkungan kerja yang lebih suportif dan profesional meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja

d. Optimalisasi Sumber Daya

- 1) Penggunaan alat medis, ruang perawatan, dan tenaga kesehatan menjadi lebih efisien.

- 2) Mengurangi pemborosan waktu dan biaya dalam proses penanganan kegawatdaruratan.
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
  - 1) Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, standar pelayanan kesehatan dapat lebih terjaga.
  - 2) Pasien dan keluarga mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam proses perawatan.
- f. Peningkatan Pembelajaran dan Pengembangan Profesional
  - 1) Kolaborasi antar profesi memungkinkan pertukaran ilmu dan keterampilan antar tenaga kesehatan.
  - 2) Meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai kasus darurat melalui pengalaman tim yang lebih luas

Dengan dampak-dampak tersebut, kolaborasi antar profesi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem kegawatdaruratan, memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan terbaik dalam kondisi yang sering kali penuh tekanan dan keterbatasan waktu.

## **G. Simpulan**

---

Kerja tim dan kolaborasi antar profesi dalam penanganan gawat darurat sangat penting untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang cepat, tepat, dan efektif. Dalam situasi darurat, tenaga medis seperti dokter, perawat, paramedis, dan profesi kesehatan lainnya harus bekerja secara sinergis dengan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik.

Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang harus dijalankan secara profesional untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Kolaborasi yang baik juga melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi pasien, standar prosedur, serta pengalaman masing-masing tenaga medis.

Dengan kerja tim yang solid dan koordinasi yang efektif, pelayanan gawat darurat dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan peluang keselamatan pasien, serta mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius. Oleh karena itu, pelatihan rutin dan simulasi keadaan darurat sangat diperlukan untuk memperkuat keterampilan kolaborasi antar profesi di lingkungan medis.

## H. Referensi

---

- Abi Sujak, 1990. *Kepemimpinan Manajer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Alamri, A., A.I. Cristea, and M.S. Al-Zaidi. 2014. Saudi Arabian cultural factors and personalized learning. In *Proceedings of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies*, 7–9 July 2014, Barcelona, Spain, 7114–712.
- Alahmadi, H. A. (2010). Assessment of patient safety culture in Saudi Arabian hospitals. *Quality and Safety in Health Care*, 19(5), 1–6. <https://doi.org/10.1136/qshc.2009.033258>
- Alandijany, T. A., Faizo, A. A., & Azhar, E. I. (2020). Coronavirus disease of 2019 (COVID-19) in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Current status and management practices. *Journal of Infection and Public Health*, 13(6),

839–842. <https://doi.org/10.1016/j.jjiph.2020.05.020>

- Aldulaimi, S. H. (2019). Leadership concept and constructs in Arabic philosophy. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 40(2), 193–210.
- Arsyadana, A. (2019). Dasar-Dasar Perilaku Kelompok dan Memahami Tim Kerja dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Prosiding Nasional*, 2(November), 213–232.
- Bertha Margareth. (2023). Anxiety First Aid: 10 Tips cepat saat Anda Mengalami Kecemasan Mendadak". In *Carolus Journal of Nursing*, (Vol. 2).
- Cohen Konrad, S., Fletcher, S., Hood, R., & Patel, K. (2019). Theories of power in interprofessional research—developing the field. *Journal of Interprofessional Care*, 33(5), 401–405. <https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1669544>
- DeFeo, R. M. (2021). *Faculty Perceptions Of Self Efficacy In Interprofessional Healthcare Education*. <https://dune.une.edu/theses>
- Diefenbach, T., & Sillince, J. A. A. (2011). Formal and informal hierarchy in different types of organization. *Organization Studies*, 32(11), 1515–1537. <https://doi.org/10.1177/0170840611421254>
- Finn, R., Learmonth, M., & Reedy, P. (2010). Some unintended effects of teamwork in healthcare. *Social Science and Medicine*, 70(8), 1148–1154. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.12.025>
- Gooding, K., Bertone, M. P., Loffreda, G., & Witter, S. (2022). How can we strengthen partnership and coordination for health

system emergency preparedness and response? Findings from a synthesis of experience across countries facing shocks. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08859-6>

Grossman, R., Campo, M. S., Feitosa, J., & Salas, E. (2021). Cross-cultural perspectives on collaboration: Differences between the Middle East and the United States. *Journal of Business Research*, 129(February), 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.031>

Ita, K., Pramana, Y., & Riggo, A. (2021). Implementasi interprofessional collaboration antar tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Indonesia : Literature review. *Jurnal ProNers*, 6(1), 1–6.

Jamshidi, H., Jazani, R. K., Alibabaei, A., Alamdari, S., & Kalyani, M. N. (2019). Challenges of cooperation between the pre-hospital and in-hospital emergency services in the handover of victims of road traffic accidents: A qualitative study. *Investigacion y Educacion En Enfermeria*, 37(1). <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v37n1e08>

Jayawisastra, P. (2022). Literatur Review: Analisis Strategi Manajemen Konflik Perawat Manajer dg Pendekatan Kolaborasi di IGD RS X Depok. *Indonesian Journal of Nursing Scientific*, 2(2), 45–57. <https://doi.org/10.58467/ijons.v2i2.39>

Jill Thistlethwaite. (2012). *Values-Based Interprofessional Collaborative Practice: Working Together in Health Care*.

Lasmi, A., Bayhaqi, H., & Suhairi, S. (2021). Membangun Kerjasama Tim yang Efekti dalam Organisasi. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i1.509>

- Morato, A. G. D., Diarthini, N. L. P. E., & Utami, D. K. I. (2021). Literature Review: Efektivitas Interprofessional Education (IPE) Terhadap Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi antar Profesi Kesehatan. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 322–329. <https://doi.org/10.26630/jk.v12i2.2264>
- Mostafa, M. M. (2003). Attitudes towards women who work in Egypt. *Women in Management Review*, 18(5), 252–266. <https://doi.org/10.1108/09649420310485096>
- Moussa, F. L., Moussa, M., Sofyani, H. A., Alblowi, B. H., Oqdi, Y. A., Khallaf, S., Alharbi, H. S., & Albarqi, A. (2022). Attitudes of Critical Care Nurses towards Teamwork and Patient Safety in Saudi Arabia: A Descriptive Cross-Sectional Assessment. *Healthcare (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/healthcare10101866>
- Murdoch, J., Murphy, G. T., Alder, R., Gilbert, J., & Steenbeek, A. (2018). Readiness to Collaborate Scale: How ready are obstetrical practitioners to participate in an interprofessional healthcare team? *Journal of Interprofessional Education & Practice*. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2018.09.004>
- Patima. (2021). *Pengembangan Model Interprofessional Collaboration Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Sulawesi Selatan*.
- Putriana, N. A., & Saragih, Y. B. (2020). Pendidikan Interprofessional dan Kolaborasi Interprofesional. *Majalah Farmasetika*, 5(1), 18–22. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i1.25626>
- Robertson, C. J., Al-Khatib, J. A., & Al-Habib, M. (2002). The relationship between Arab values and work beliefs: An exploratory examination. *Thunderbird International*

*Business Review*, 44(5), 583–601.  
<https://doi.org/10.1002/tie.10036>

Schmutz, J. B., Meier, L. L., & Manser, T. (2019). How effective is teamwork really? The relationship between teamwork and performance in healthcare teams: A systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*, 9(9), 1–16.  
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028280>

Shackleton, V. J., & Ali, A. H. (1990). Work-related values of managers: A Test of the Hofstede Model. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 21(1), 109–118.  
<https://doi.org/10.1177/0022022190211005>

Syaifullah, A. A. S. J. (2008). Komunikasi Organisasi. In *Wade Grup*.  
<https://ipolbluek.wordpress.com/2008/05/15/kemitraan-dalam-promosi-kesehatan/>

Yaseen, Z. (2010). Leadership styles of men and women in the Arab world. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, 3(1), 63–70.  
<https://doi.org/10.1108/17537981011022823>

Zakarya Ali Qasem Ghalib. (2019). *Impact of Human Capital Development and Human Capital Isolation Mechanisms on Innovative Performance: Evidence from Industrial Companies in Jordan*. 11(15), 117–129.  
<https://doi.org/10.7176/EJBM>

## **I. Glosarium**

---

*WHO: World Health Organization*



# CHAPTER 3

## TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM TRIASE PASIEN: MENENTUKAN PRIORITAS PERAWATAN

Vita Maryah Ardiyani, S.Kep., Ns., M.Kep.

### A. Pendahuluan

---

Dalam situasi pelayanan kesehatan yang dinamis dan seringkali penuh tekanan, seperti di unit gawat darurat (UGD) atau saat terjadi bencana massal, sistem triase menjadi komponen krusial dalam menentukan efektivitas penanganan pasien. Triase merupakan proses sistematis untuk memilah dan menetapkan prioritas perawatan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan kondisi mereka. Perawat, sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, memegang peran penting dalam pelaksanaan triase ini.

Tanggung jawab perawat dalam proses triase tidak hanya sebatas melakukan penilaian awal terhadap kondisi pasien, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan cepat dan akurat untuk memastikan bahwa pasien yang membutuhkan intervensi segera mendapatkan perawatan yang sesuai dalam waktu yang tepat. Keberhasilan triase sangat bergantung pada kompetensi klinis, ketajaman

penilaian, serta kemampuan komunikasi dan koordinasi dari seorang perawat.

Oleh karena itu, memahami secara mendalam tanggung jawab perawat dalam triase pasien menjadi hal yang sangat penting, baik dalam konteks pendidikan keperawatan maupun praktik klinis. Pengetahuan dan keterampilan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan keselamatan jiwa pasien.

## **B. Konsep Triage**

---

### **1. Definisi *Triage***

Menurut Broadbent, et al (2004) *triage* berasal dari bahasa Perancis yaitu "trier" yang berarti memilih. *Triage* dan *initial assessment* merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk mendeteksi secara dini dan mencegah kondisi yang mengancam kehidupan (Sands, 2009). Dapat disimpulkan bahwa *triage* merupakan sebuah kegiatan pengelompokan atau penggolongan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya.

Florence Nightingale menggunakan konsep *triage* selama perang crime dengan cara memilih korban perang yang mungkin atau tidak mungkin bertahan hidup dan memerlukan perawatan lebih lanjut (Thomas, Bernardo & Herman 2003, dalam Semonin, 2008) Pada tahun 1960 *triage* mulai berkembang dan dilakukan di unit gawat darurat. Awalnya *triage* dilakukan oleh dokter atau tim yang terdiri dari dokter dan perawat, saat ini *triage*

umumnya dilakukan oleh seorang perawat unit gawat darurat yang telah berpengalaman (Gilboy, Travers & Wuerz 1999, dalam Semonin, 2008)

*Triage* didefinisikan sebagai suatu sistem seleksi dan pemilihan pasien untuk menentukan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan pasien (DepKes RI, 2005). Lebih lanjut Kathleen & Oman, (2008) mendefinisikan *triage* sebagai suatu konsep pengkajian yang cepat dan terfokus dengan suatu cara yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang paling efisien dengan tujuan untuk memilih atau menggolongkan semua pasien yang memerlukan pertolongan dan memprioritaskan penanganannya.

## **2. Tujuan *Triage***

Tujuan dari tindakan *triage* adalah untuk menempatkan pasien pada tempat yang tepat sesuai dengan tingkat kegawatannya. Lebih rinci semonin, (2008); Elliot, et al, (2007). Menjelaskan tujuan dari *triage* yaitu untuk pengkajian pasien yang lebih awal dan singkat, penentuan dari penanganan pasien yang mendesak, mendokumentasikan temuan, mengontrol alur pasien di unit gawat darurat, menempatkan pasien pada area perawatan yang sesuai, awal dari tindakan diagnostik dan intervensi terapeutik yang terbatas, dapat mengontrol infeksi dan untuk pendidikan kesehatan bagi pasien.

Ruang *triage* digunakan untuk menyeleksi pasien sesuai dengan tingkat kegawatan penyakitnya. Lokasi

ruang *triage* yang ideal adalah area dekat pintu masuk pasien tetapi memungkinkan pasien dan pemeriksa mendapatkan lokasi yang tenang dan juga berdekatan dengan area perawatan akut dan resusitasi. Ruang *triage* dilengkapi oleh peralatan dasar yaitu meja, thermometer, sphygmomanometer, stetoskop dan peralatan monitoring lain seperti glucometer dan pulse oximetry Elliott et al,( 2007). Kepmenkes (2005), menjabarkan kriteria dari ruang *triage* yang terletak berdampingan dengan tempat perawat/ dokter jaga, sehingga dapat dengan mudah mengawasi semua kegiatan di pintu masuk, ruang tunggu, ruang tindakan dan ruang resusitasi. Dalam ruang *triage* juga tersedia kit pemeriksaan sederhana, brankar penerimaan pasien, pembuatan rekam medis khusus dan pemberian label, kapasitas ruangan hendaknya dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.

### **3. Konsep Prioritas Kegawatdaruratan Dalam *Triage***

Keperawatan gawat darurat adalah pelayanan profesioanal keperawatan yang di berikan pada pasien dengan kebutuhan urgen dan kritis. Namun IGD dan klinik kedaruratan sering di gunakan untuk masalah yang tidak urgen. Pada perkembangannya kegawatdaruratan menjadi luas, kedaruratan yaitu apapun yang di alami pasien atau keluarga harus di pertimbangkan sebagai kegawatdaruratan. Pelayanan gawat darurat tidak hanya memberikan pelayanan untuk mengatasi kondisi kedaruratan yang di alami pasien tetapi juga memberikan

masuk ke perawatan untuk mengatasi kecemasan pasien dan keluarga. Sistem pelayanan bersifat darurat sehingga perawat dan tenaga medis lainnya harus memiliki kemampuan, keterampilan, teknik serta ilmu pengetahuan yang tinggi dalam memberikan pertolongan kedaruratan kepada pasien. *Triage* dalam keperawatan gawat darurat digunakan untuk mengklasifikasikan keparahan penyakit atau cedera dan menetapkan prioritas kebutuhan penggunaan petugas perawatan kesehatan secara efisien. Standar waktu yang diperlukan untuk melakukan triase adalah 2-5 menit untuk orang dewasa dan 7 menit untuk pasien anak-anak (Angkas, MP, 2022).

*Manchester Triage Group* menjelaskan beberapa strategi pengambilan keputusan *triage* antara lain pertimbangan (*reasoning*), pola pengakuan (*pattern recognition*), hipotesis berulang (*repetitive hypothesizing*), representasi mental (*mental representation*), dan intuisi (*intuition*) (Mackway *et al.*, 2006).

a. Pertimbangan (*reasoning*)

Pada dasarnya ada dua jenis penalaran yang terlibat dalam berpikir kritis yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah kemampuan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan dari khusus ke umum dan sangat berguna untuk perawat yang kurang berpengalaman. Sedangkan penalaran deduktif adalah penalaran dari umum ke khusus. Hal ini memungkinkan praktisi untuk secara cepat menyortir

informasi relevan dari yang tidak relevan untuk mencapai keputusan.

b. Pola pengakuan (*pattern recognition*)

Merupakan strategi yang paling umum digunakan dokter dan sangat penting ketika membuat keputusan cepat berdasarkan informasi terbatas yang diperlukan selama *triage* berdasarkan pola tanda dan gejala pasien dibandingkan dengan kondisi dari kasus sebelumnya. Kemampuan dalam penggunaan keterampilan pengambilan keputusan ini berkembang dari pengalaman dan intuisi.

c. Hipotesis berulang (*repetitive hypothesizing*)

Hipotesis berulang digunakan oleh dokter untuk menguji penalaran diagnostik. Data dikumpulkan untuk mengkonfirmasi atau menghilangkan hipotesis, sehingga keputusan dapat dibuat. Metode ini tergantung pada tingkat keahlian dapat berupa induktif atau deduktif.

d. 4) Representasi mental (*mental representation*)

Representasi mental adalah metode untuk menyederhanakan situasi untuk memberikan gambaran umum dan memungkinkan fokus pada informasi yang relevan. Strategi ini sering digunakan ketika masalah sangat kompleks atau luar biasa. Keputusan *triage* harus cepat dan metode ini memiliki penggunaan terbatas dalam tahap perawatan pasien.

e. Intuisi (intuition)

Intuisi terkait erat dengan keahlian dan umumnya dianggap sebagai kemampuan praktisi untuk memecahkan masalah dengan data yang relatif sedikit. Intuisi jarang melibatkan analisis sadar dan sering dinyatakan sebagai 'firasat'. Praktisi ahli melihat situasi secara holistik dan pengalaman masa lalu. Keputusan yang efektif dibuat dengan menggabungkan pengetahuan dengan teori pengambilan keputusan dan pemikiran intuitif.

Prinsip dalam menentukan prioritas keputusan *triage* adalah berdasarkan Hirarki Kebutuhan Maslow dimana dalam kerangkanya menyatakan kebutuhan paling mendasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang paling tinggi yaitu mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan mencintai, harga diri, dan aktualisasi diri. Di departemen gawat darurat hal ini dijabarkan dalam ABCD yaitu memenuhi kebutuhan jalan nafas (*Airway*), kemudian pernafasan (*Breathing*), kemudian sirkulasi (*Circulation*), kemudian cacat (*Disability*) (Zimmermann & Herr, 2006) (HU et al 2022).

*Triage* di lakukan oleh perawat yang profesional (RN) yang sudah terlatih dalam prinsip triase, pengalaman bekerja minimal 6 bulan di bagian UGD, dan memiliki kualifikasi: - Menunjukkan kompetensi kegawat daruratan , Sertifikasi ATLS, ACLS, PALS, ENPCLulus Trauma Nurse Core Currikulum (TNCC),Pengetahuan tentang kebijakan intradepartemen dan Keterampilan

pengkajian yang tepat. Berbagai sistem menggambarkan kategori *triage* dengan menggunakan label *triage* dan definisi dari masing-masing kelompok / tingkatan. Berikut contoh pengkategorian sistem pengelompokan *triage* :

- a. Sistem *triage* 2 kelompok : *emergent, non emergent*
- b. Sistem *triage* 3 kelompok : *emergent, urgent, non urgent*
- c. Sistem *triage* 4 kelompok : *life threatening, emergent, urgent, non urgent*
- d. Sistem *triage* 5 kelompok : *resuscitation, emergent, urgent, non urgent, referred.*

ACEP (*American College of Emergency Physician*) dan ENA (*Emergency Nursing Association*) mendukung pengelompokan *triage* dalam 5 kelompok (Gilboy, 2005). Beberapa contoh sistem *triage* 5 kelompok, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

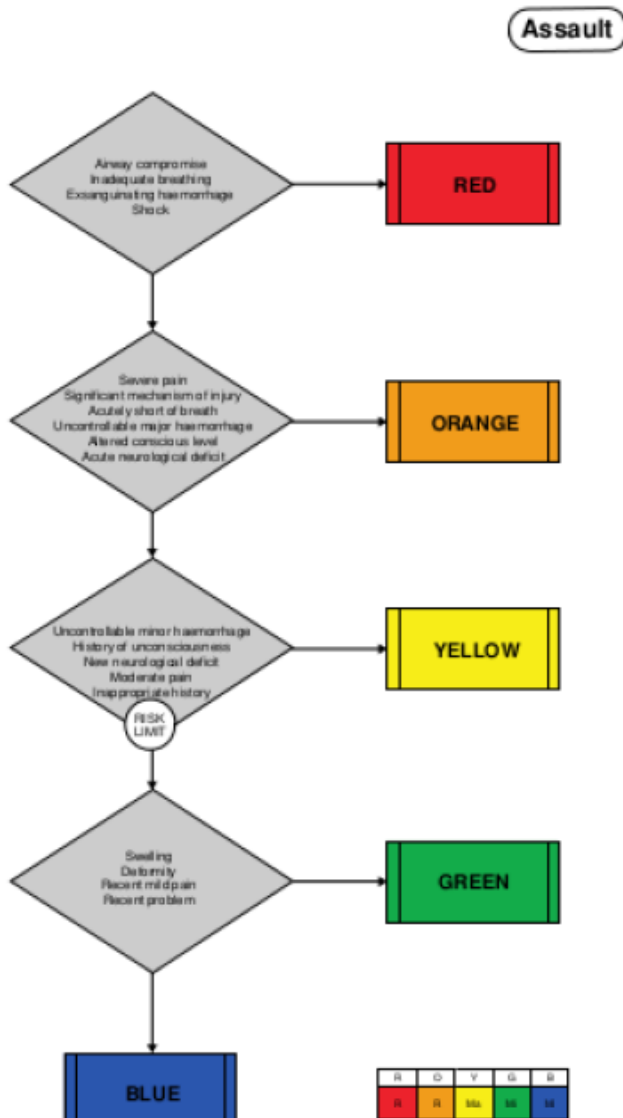
**Tabel 3.1 Sistem *Triage* Lima Kelompok**

| Sistem                         | Negara                   | Kategori / kelompok                                                                    | Target waktu penanganan                                           |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Australian <i>Triage</i> Scale | Australia<br>New Zealand | 1. Resuscitation<br>2. Emergency<br>3. Urgent<br>4. Semi urgent<br>5. Non urgent       | Segera / 0 menit<br>10 menit<br>30 menit<br>60 menit<br>120 menit |
| Manchester                     | Inggris<br>Scotlandia    | 1-Immediate (red)<br>2-Very urgent (orange)<br>3-Urgent (yellow)<br>4-Standard (green) | 0 menit<br>10 menit<br>60 menit<br>120 menit<br>240 menit         |

|                                                         |        |                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         |        | 5-Non urgent<br>(blue)                                                          |                                                          |
| Canadian<br><i>Triage</i> and<br>Acuity Scale<br>(CTAS) | Canada | 1- Resuscitation<br>2- Emergent<br>3- Urgent<br>4- Less urgent<br>5- Non urgent | 0 menit<br>15 menit<br>30 menit<br>60 menit<br>120 menit |

(Australasian College for Emergency Medicine, 2002; Canadian Association of Emergency Physicians, 2002; Manchester *Triage* Group, 1997, dalam Gilboy et al, 2005, Cape *triage* Score, 2005) 2005, Cape triage Score, 2005)

Setelah melakukan penilaian, korban dikategorikan sesuai dengan kondisinya dan diberi *tag* warna. Berikut ini kategori *triage* yang terdiri dari lima kategori tingkat kegawatan untuk kasus cedera yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini.



**Gambar 3.1 *Manchester Group Triage* (Mackway *et al.*, 2006)**

Berdasarkan Gambar 2.6 kategori *triage* dibagi atas lima tingkat yaitu *immediate* (merah), *very urgent* (orange), *urgent* (kuning), *standart* (hijau), dan *non urgent* (biru) (Mackway *et al.*, 2006):

### **1. *Immediate/segera* (merah)**

Setiap korban dengan kondisi yang mengancam jiwa dan dapat mematikan dalam ukuran menit, harus ditangani dengan segera dengan waktu penanganan 0 menit. Kondisi penderita pada kondisi ini antara lain:

- a. *Airway*: tidak paten
- b. *Breathing*: pernafasan inadekuat atau tidak adanya pernapasan yang didefinisikan sebagai tidak ada respirasi atau usaha pernapasan sebagaimana dinilai dengan melihat, mendengar dan merasakan selama 10 detik.
- c. *Circulation*: tidak teraba nadi dalam waktu 5 detik dan tanda-tanda klasik syok yaitu berkeringat, pucat, takikardia, hipotensi, dan penurunan tingkat kesadaran. Terdapat perdarahan terus-menerus.
- d. *Disability*: tidak sadar dimana pada pasien dewasa tidak responsive terhadap suara dan nyeri, sedangkan pada pasien anak hanya responsive terhadap suara dan nyeri saja, hiperglikemia (Mackway *et al.*, 2006), koma dan GCS < 10 (Jayashree & Singhi, 2011).

### **2. *Very urgent/sangat mendesak* (orange)**

Setiap korban dengan kondisi cedera berat namun penanganannya dapat ditunda dengan waktu penanganan 10 menit dengan kondisi penderita:

- a. *Breathing*: SaO<sub>2</sub> sangat rendah, sesak nafas akut/tiba-tiba atau sesak nafas kronis
- b. *Circulation*: nadi abnormal, takikardi, perdarahan mayor yang tidak terkontrol
- c. *Disability*: perubahan tingkat kesadaran, defisit neurologis akut. Hilangnya fungsi neurologis yang datang dalam 24 jam sebelumnya. Termasuk perubahan atau hilangnya sensasi, kelemahan tungkai (baik transien atau permanen) dan perubahan dalam kandung kemih atau fungsi usus.
- d. Nyeri berat
- e. Mekanisme kecelakaan yang signifikan. Luka tembus (tusuk atau tembakan), jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas yang signifikan (kecepatan > 40 m/jam) terutama jika telah ada ejeksi dari kendaraan, kematian korban kecelakaan lainnya atau ditandai perubahan bentuk kendaraan

### 3. ***Urgent/mendesak (kuning)***

Waktu penanganan 60 menit dan kondisi penderita antara lain:

- a. *Circulation*: perdarahan minor yang terkontrol
- b. *Disability*: riwayat tidak sadarkan diri oleh saksi yang menyatakan apakah pasien tidak sadarkan diri (dan untuk berapa lama). Jika seorang pasien yang tidak dapat mengingat insiden itu harus diasumsikan telah menjadi sadar dan defisit neurologis baru terjadi
- c. Nyeri sedang

- d. Riwayat tidak wajar (*inappropriate*) yang diberikan tidak menjelaskan fisik, temuan itu disebut tidak wajar yang merupakan penanda cedera non kecelakaan pada yang mungkin dikarenakan penyalahgunaan pada anak-anak yang rentan dan dewasa.

#### **4. *Standart* (hijau)**

Kondisi penderita antara lain terdapat pembengkakan, deformitas, nyeri ringan, dan masalah actual dengan waktu penanganan 120 menit.

#### **5. *Non urgent/tidak mendesak* (biru)**

Sama dengan pada kondisi *standart* (hijau) tetapi waktu penanganan hingga 240 menit.

Kategori *triage* pada pasien trauma dalam sistem triage tiga tingkat antara lain (Zimmermann & Herr, 2006):

##### **1. Prioritas 1 (merah)**

Kondisi pasien membutuhkan resusitasi. *The American College of Surgeons* (ACS), *Committee on Trauma* menyarankan pasien ditangani dipusat trauma. Waktu tunggu untuk penanganan pasien adalah 0 menit. Kriteria pasien dalam prioritas I antara lain:

- a. *Glasgow Coma Scale* (GCS): <14
- b. Tekanan darah sistolik: <90 mmHg
- c. Frekuensi pernafasan: <10 atau >29 x/menit
- d. *Revised trauma score*: <11
- e. Cedera tusuk pada kepala, leher, *torso*, ekstremitas proksimal sampai siku dan lutut
- f. *Flail chest*
- g. Kombinasi trauma dan luka bakar

- h. Fraktur dua atau lebih tulang panjang
- i. Fraktur pelvis
- j. Fraktur kepala terbuka
- k. *Paralysis*
- l. Amputasi sampai pergelangan tangan dan kaki proksimal
- m. Luka bakar mayor
- n. Ejeksi dari mobil
- o. Kematian pada kompartemen penumpang yang sama
- p. Jatuh dari ketinggian >20 kaki
- q. Kecelakaan mobil kecepatan tinggi (>40 mil per jam), perubahan bentuk kendaraan >20 inci, *intrusi* ke kompartemen penumpang >12"
- r. Kecelakaan motor dengan kecepatan >20 mil per jam atau pengendara terpisah dari motor
- s. Pasien berusia <5 tahun atau >55 tahun, hamil, kondisi medis kronis

## **2. Prioritas 2 (kuning)**

Kondisi pasien yang mendesak (urgent) stabil, tetapi memiliki potensi memburuk atau perlu dilihat sesegera mungkin. Kondisi dapat digambarkan akut, tetapi tidak "parah". Contoh kondisi dalam kategori ini adalah fraktur terbuka, luka bakar minor, dan pembedahan abdomen. Waktu tunggu untuk penanganan pasien adalah 30 menit.

## **3. Prioritas 3 (hijau)**

Kondisi pasien tidak mendesak (*non urgent*), biasanya dinamakan "*walking wounded*", contohnya pada

kondisi *laserasi minor* (perdarahan terkontrol) atau fraktur ekstremitas yang stabil

Sistem *triage* yang diterapkan di Indonesia adalah kategori triage tiga tingkat yaitu Prioritas 1 atau gawat darurat (merah), Prioritas 2 atau gawat tapi tidak darurat (kuning), dan Prioritas 3 atau tidak gawat dan tidak darurat (hijau). Berdasarkan kategori gawat dan tidak gawat, maka yang masuk dalam kategori gawat adalah Prioritas 1 (merah) dan Prioritas 2 (kuning), sedangkan yang masuk dalam kategori tidak gawat adalah Prioritas 3 (hijau).

Canadian *Triage and Acuity Scale* (CTAS), merupakan *guideline* nasional yang di adopsi oleh beberapa negara yang belum memiliki model *triage* tetap. Deskripsi dari CTAS dalam mengkategorikan pasien adalah sebagai berikut:

- a. CTAS Level 1 - *Resuscitation* (Pasien harus dilihat segera)  
Kondisi yang mengancam jiwa atau anggota tubuh (resiko tinggi untuk mengalami penurunan kondisi) seperti Cardiac/ Respirasi arrest, *Mayor* trauma, pasien tidak sadar, distress pernafasan, syok.
- b. CTAS Level 2 – *Emergent* (pasien harus dilihat dalam waktu 15 menit) Kondisi yang berpotensi mengancam fungsi hidup, yang memerlukan intervensi medis yang cepat atau dapat di delegasikan, perubahan status mental, cedera kepala, trauma berat, neonatus,

overdosis obat-obatan dan *Cardio Vascular Attack* (CVA), Sesak nafas, fraktur yang parah.

- c. CTAS Level 3 – *Urgent* (pasien harus dilihat dalam waktu 30 menit)

Kondisi yang berpotensi berkembang menjadi masalah serius yang memerlukan intervensi darurat, dapat berhubungan dengan ketidaknyamanan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Seperti: Trauma sedang, Perdarahan GI track, perdarahan vagina dan kehamilan, psikosis akut / Suicide, nyeri akut, asma.

- d. CTAS Level 4 - *Less Urgent/ semi urgent* (pasien harus dilihat dalam waktu 60 menit). Kondisi yang terkait dengan usia pasien, distress, potensi kerusakan/komplikasi akan dapat di atasi dengan intervensi dalam waktu 1-2 jam. Seperti: sakit kepala, Benda asing dalam kornea, *cronic back pain*.

- e. CTAS Level 5 – *Non Urgent* (pasien harus dilihat dalam waktu 120 menit)

Kondisi yang mungkin akut tetapi tidak mendesak. Seperti: Sakit tenggorokan, nyeri perut ringan yang berulang atau kronis, dengan tanda vital yang normal, muntah saja atau diareha saja (Foly et al, 2019).

### **C. Konsep Peran Perawat**

---

Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial seseorang baik dari faktor internal maupun

eksternal (Kozier and Barbara, 1995). Perawat mengemban beberapa peran saat mereka memberi asuhan kepada kliennya. Perawat sering menjalankan peran ini secara bersamaan, tanpa membedakan satu peran dengan yang lain. Sebagai contoh, perawat dapat bertindak sebagai seorang konsultan saat memberi perawatan fisik dan memberi penyuluhan tentang aspek asuhan yang diberikan tersebut. Peran yang dibutuhkan pada waktu tertentu bergantung pada kebutuhan klien dan aspek dalam lingkungan tertentu. Perawat profesional menuntut perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang. Pada waktu lampau peran perawat inti adalah memberikan perawatan dan kenyamanan karena mereka menjalankan fungsi perawatan spesifik, namun hal ini telah berubah, peran perawat menjadi lebih luas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, juga memandang klien secara komprehensif. Perawat profesional menjalankan fungsi dalam kaitannya dengan berbagai peran perawatan, pembuat keputusan klinik dan etika, pelindung dan advokat bagi klien, manajer kasus, rehabilitator, pembuat kenyamanan, komunikator, dan pendidik. Berikut beberapa peran perawat (Barbara et al, 2010 & Potter and Peryy, 2005):

### **1. Pemberi Asuhan**

Sejak dahulu, peran pemberi asuhan meliputi tindakan yang membantu klien secara fisik maupun psikologis sambil tetap memelihara martabat klien. Tindakan keperawatan yang dibutuhkan dapat berupa

asuhan total bagi klien yang mengalami ketergantungan total, asuhan parsial bagi pasien dengan tingkat ketergantungan sebagian, dan perawatan suportif-edukatif untuk membantu klien mencapai kemungkinan tingkat kesehatan dan kesejahteraan tertinggi. Pemberian asuhan mencakup asuhan fisik, psikososial, perkembangan, budaya, dan spiritual. Kerangka kerja pemberian asuhan bagi perawat tercakup dalam proses keperawatan. Seorang perawat dapat memberikan asuhan secara langsung atau mendelegasikannya ke pemberi asuhan lain. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik, meliputi upaya mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial. Pemberi asuhan memberikan bantuan bagi klien dan keluarga dalam menetapkan tujuan dan mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan energi dan waktu yang minimal ((Amri et al, 2019).

## **2. Komunikator**

Komunikasi merupakan bagian tak terpisahkan dari semua peran perawat. Perawat berkomunikasi dengan klien, orang pendukung, profesional kesehatan lain, dan individu yang ada dalam masyarakat. Dalam perannya sebagai komunikator, perawat mengidentifikasi masalah klien dan kemudian mengomunikasikan hal ini secara verbal atau tertulis kepada anggota lain dalam tim

kesehatan. Kualitas komunikasi seorang perawat merupakan faktor penting dalam asuhan keperawatan. Perawat harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan akurat agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan klien. Peran sebagai komunikator merupakan pusat dari seluruh peran perawat yang lain. Keperawatan mencakup komunikasi dengan klien dan keluarga, antar-sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, sumber informasi dan komunitas. Memberikan perawatan yang efektif, pembuatan keputusan klien dan keluarga, memberikan perlindungan bagi klien dari ancaman terhadap kesehatannya, mengoordinasi dan mengatur asuhan keperawatan, membantu klien dalam rehabilitasi, memberikan kenyamanan atau mengajarkan sesuatu pada klien tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi yang jelas (Amri et al, 2019).

### **3. Pendidik**

Sebagai seorang pendidik, perawat membantu klien mengenal kesehatan dan prosedur asuhan kesehatan yang perlu mereka lakukan guna memulihkan atau memelihara kesehatan. Perawat mengkaji kebutuhan belajar dan kesiapan belajar klien, menentukan tujuan belajar khusus bersama klien, menerapkan strategi pendidikan, dan mengukur hasil belajar. Perawat juga mengajari staf penerima delegasi asuhan, staf bantu yang belum memiliki izin (*Unlicense Assitive Personel/UAP*), dan membagi keahlian mereka dengan perawat atau profesional kesehatan lain. Perawat pendidik bekerja

terutama di sekolah keperawatan, departemen pengembangan staf dari suatu lembaga perawatan kesehatan, dan departemen pendidikan klien. Perawat pendidik secara umum memiliki latar belakang pengalaman klinis yang memberikan mereka keahlian klinis dan pengetahuan teoritis.

Seorang pendidik di fakultas keperawatan menyiapkan peserta didiknya untuk berfungsi sebagai perawat. Staf fakultas keperawatan bertanggung jawab terhadap pendidikan terkini dalam melaksanakan teori keperawatan dan keterampilan khusus di laboratorium atau di klinik. Perawat pendidik di fakultas keperawatan biasanya dituntut memiliki ijazah dari pendidikan keperawatan. Selain itu mereka secara umum memiliki spesialisasi klinis di bidang tertentu dan pengalaman klinis lanjutan. Perawat pendidik di departemen pengembangan staf dari institusi kesehatan tertentu memberikan program pendidikan bagi perawat yang bekerja di institusinya. Program ini meliputi orientasi beberapa karyawan baru, kursus asuhan perawatan kritis, dan instruksi mengenai alat-alat dan prosedur baru. Fokus utama dari perawat pendidik adalah memberikan pendidikan klien yang mengajarkan klien yang sakit atau tidak mampu dan keluarganya untuk melakukan perawatan mandiri di rumah (Amri et al, 2019)

#### **4. Advokat Klien**

Advokat klien bertindak melindungi klien. Dalam peran ini, perawat dapat mewakili kebutuhan dan harapan

klien kepada profesional kesehatan lain, seperti menyampaikan keinginan klien mengenai informasi yang ingin ia ketahui kepada dokter. Perawat juga membantu klien mendapatkan hak-haknya dan membantu mereka menyampaikan keinginan mereka sendiri. Sebagai pelindung perawat membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik atau pengobatan. Memastikan bahwa klien tidak memiliki alergi terhadap obat dan memberikan imunisasi melawan penyakit di komunitas merupakan contoh dari peran perawat sebagai pelindung. Dalam menjalankan perannya sebagai advokat, perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan memberikan pengetahuan hak-hak tersebut secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Sebagai contoh perawat memberikan informasi tambahan bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya. Perawat juga melindungi hak-hak klien melalui cara-cara yang umum dengan menolak aturan atau tindakan yang mungkin membahayakan kesehatan klien atau menantang hak-hak klien (Amri et al, 2019).

## **5. Konselor**

Konseling adalah proses membantu klien untuk mengenali dan menghadapi masalah-masalah psikologis dan sosial yang sangat menekan, untuk membina

hubungan interpersonal yang sudah membaik, dan untuk meningkatkan perkembangan personal. Konseling melibatkan pemberian dukungan emosi, intelektual, dan psikologis. Perawat memberikan konsultasi terutama kepada individu sehat dengan kesulitan penyesuaian diri yang normal dan berfokus dalam membantu individu tersebut untuk mengembangkan sikap, perasaan, dan perilaku baru dengan cara mendorong klien untuk mencari perilaku alternatif, mengenali pilihan-pilihan yang tersedia, dan mengembangkan

## **6. Agen Pengubah**

Perawat bertindak sebagai agen pengubah saat membantu orang lain, yakni klien, memodifikasi perilaku mereka. Perawat juga sering berperan serta untuk melakukan perubahan dalam satu sistem, misalnya asuhan klinis, jika hal ini tidak membantu klien kembali ke kondisi kesehatannya. Perawat secara berkelanjutan berhubungan dengan perubahan dalam sistem asuhan kesehatan. Perubahan teknologi, perubahan usia populasi klien, dan perubahan pengobatan yang digunakan sebenarnya hanya segelintir perubahan yang dihadapi oleh perawat setiap hari. Perawat sebagai agen pengubah harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dan mengaplikasikan serta mensosialisasikan perubahan-perubahan tersebut dalam langkah meningkatkan kualitas asuhan keperawatan (Barbara et al, (2010) , Potter and Peryy, (2005)).

## **7. Pemimpin**

Seorang pemimpin memengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Peran pemimpin dapat diterapkan pada tingkatan yang berbeda, yakni pada klien perorangan, kelompok klien, kolega, ataupun komunitas. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses belajar yang memerlukan pemahaman terhadap kebutuhan dan tujuan yang memotivasi orang lain, pengetahuan untuk menerapkan ketrampilan memimpin, dan kemampuan interpersonal untuk memengaruhi orang lain.

## **8. Manajer**

Perawat mengatur pemberian asuhan keperawatan bagi individu, keluarga, dan komunitas. Perawat manajer juga mendelegasikan tindakan keperawatan kepada para staf pendukung dan perawat lain, dan memantau serta mengevaluasi kinerja mereka. Kegiatan mengatur membutuhkan pengetahuan mengenai struktur dan dinamika organisasi, kewenangan dan tanggung jawab, kepemimpinan, teori perubahan, advokasi, delegasi, dan supervisi serta evaluasi. Sebagai manajer kasus, perawat mengoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lain, misalnya ahli gizi dan ahli terapi. Selain itu perawat juga mengatur waktu kerja dan sumber yang tersedia di tempat kerjanya. Berkembangnya model praktik memberika perawat kesempatan untuk membuat pilihan jalur karier yang ingin ditempuhnya. Adanya berbagai tempat kerja, perawat dapat memilih peran sebagai

manajer asosiasi yang melaksanakan keputusan manajer. Sebagai manajer, perawat mengoordinasi dan mendelegasikan tanggung jawab asuhan dan mengawasi tenaga kesehatan lainnya

Perawat sebagai manajer kasus bekerja dalam tim asuhan kesehatan multidisiplin untuk mengukur efektivitas rencana manajemen kasus dan untuk memantau hasil. Setiap lembaga atau unit menyebutkan peran perawat sebagai manajemen kasus. Pada beberapa institusi, manajer kasus bekerja dengan perawat primer atau staf perawat untuk mengawasi asuhan dari beban kasus tertentu. Di lembaga lain, manajer kasus adalah perawat primer atau perawat yang memberikan beberapa tingkatan perawatan langsung kepada klien dan keluarga. Perusahaan asuransi juga telah mengembangkan sejumlah peran bagi perawat manajer kasus dan memberikan tanggung jawab yang beragam mulai dari mengelola hospitalisasi kasus akut hingga mengelola klien yang membutuhkan biaya tinggi atau jenis kasus yang berbeda (Lindayani et al, 2024).

## **D. Tugas dan Peran Perawat Triage**

---

*Triage* merupakan salah satu peran yang dimiliki oleh perawat unit gawat darurat, yang merupakan peran inti dan otonomi perawat untuk keselamatan pasien serta efisiensi pelayanan perawatan pasien di unit gawat darurat. Menurut CENA (*College Emergency Nursing Australia*, 2007) Tugas perawat *triage* adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian kepada pasien dan mengkategorisasikan pasien sesuai dengan penilaian survey primer dan penilaian resiko.
2. Segera melakukan intervensi dan prosedur organisasi (seperti pertolongan pertama dan penanganan gawat darurat) untuk meningkatkan keselamatan pasien dan petugas di unit gawat darurat.
3. Melakukan penilaian secara terus menerus dan mengelola pasien yang ada di ruang tunggu sesuai dengan kondisi mereka.
4. Memberikan pendidikan kepada pasien dan masyarakat untuk memfasilitasi pendidikan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan cedera.
5. Bertindak sebagai penghubung anggota masyarakat dengan petugas kesehatan.

Terkait perannya sebagai perawat *triage*, seorang perawat *triage* hendaknya memiliki beberapa kompetensi untuk dapat melaksanakan perannya. Beberapa kualifikasi perawat *triage* menurut Grossman dalam Oman (2008) yaitu: Menguasai program orientasi kedaruratan rumah sakit, Bersertifikat ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*), PALS (*Pediatric Advanced Life Support*), Lulus ENPC (*Emergency Nurse Pediatric Course*), TNCC (*Trauma Nurse Core Curriculum*), memiliki sertifikasi dalam keperawatan gawat darurat (*Certification in Emergency Nursing / CEN*), mengetahui kebijakan intradepartemen, memahami berbagai pelayanan gawat darurat yang tersedia, trampil dalam pengkajian, komunikasi efektif, hubungan

interpersonal, penanganan konflik dan pengambilan keputusan. Pendapat lain mengenai kualifikasi perawat *triage* menurut DepKes (2005), yaitu perawat yang telah bersertifikat pelatihan PPGD (Penanggulangan Pasien Gawat Darurat) atau BTCLS (*Basic Trauma Cardiac life support*). Dari Fungsi perawat triage diatas jika dihubungkan dengan peran perawat dapat disimpulkan peran utama yang dilaksanakan perawat triage meliputi *care giver*, *leader*, *manager* dan komunikator.

## E. Referensi

---

- Amri, A., Manjas, M. and Hardisman, H. (2019) 'Analisis implementasi triage, ketepatan diagnosa awal dengan lama waktu rawatan pasien di RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(3), pp. 484–492.
- Andersson, A. K., Omberg, M & Svedlund, M. (2006). *Triage in the emergency department – a qualitative study of the factors which nurses consider when making decisions*. Journal Compilation, Vol. 11, No. 3, p. 136-145 .
- Angkasa, M.P. (2022) 'Studi Literatur: Peningkatan Keselamatan Pasien dalam Deteksi Dini Kegawatdaruratan Pasien Menggunakan Early Warning Score', *Jurnal Lintas Keperawatan*, 3(1).
- Australian College for Emergency Medicine.(2005). *Policy on the Australian Triage Scale*.[www.acem.org.au/P06 Aust Triage Scale](http://www.acem.org.au/P06_Aust_Triage_Scale). di akses 25 April 2013.

- Barbara, *et al.* (2010). *Fundamental Keperawatan Konsep, Proses dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Broadbent, M., Jarman, H., & Berk, M. (2004). *Emergency department mental health triage scales improve outcomes*. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, **10**, 1, 57–62
- College Emergency Nursing Australia. (2007). *Emergency Departement Model Of Care*. NSW Ministy Of Healt.
- Crook J.A. (2001) . *How do expert mental health nurses make on-the-spot clinical decisions? A review of the literature*. *Journal of Psychiatrics and Mental Health Nursing* 8, 1–6.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia.(2005). *Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Esensial Dasar*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Don liew, *et al.* (2003). *Emergency Departmen Length Of Stay Independency Predict Excees Inpatient Length Of Stay*. *Medical Journal* vol 179
- Elliot, D., Aitken, L., Chaboyer, W. (2007). *ACCN's Critical Care Nursing*. Australia: Elsevier.
- Fathoni, M., Sangchan, H., Praneed, S. (2010). *Triage Knowledge and Skills among Emergency Nurses in East Java Province, Indonesia*. *Conference Abstracts*. p: 153. [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- Foley, C. and Dowling, M. (2019) 'How do nurses use the early warning score in their practice? A case study from an acute medical unit', *Journal of Clinical Nursing*, 2(1), pp. 1183–1192.
- Gerdtz, M. F And Bucknall, T. K. (2001). *Triage nurses' clinical decision making. An observational study of urgency*

- assessment. Journal of Advanced Nursing*, 35: 550–561. August 2001.
- Gilboy, Nikki, et al. (2005). *Emergency Severity Index Handbook*. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Hu, H., Yao, N. and Qiu, Y. (2022) 'Predictive value of 5 early warning scores for critical COVID-19 patients', *Disaster medicine and public health preparedness*, 2(2), pp. 232–239.
- Huffman. (1994). *Waiting time and Length Of Stay Concept*. [www. Gov.on.ca](http://www.Gov.on.ca)
- Jayashree, M., & Singhi, S. (2011). *Initial Assessment and Triage in ER. Indian Journal Of Pediatrics*, 78(9), 1100–1108.
- Jus, Erwan. (2008). *Factor Influencing Length Of Stay In The Emergency Department In a Private Hospital In North Jakarta*. *Mediana* Vol 27 no.4.
- Khairina, I. (2018) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Keputusan Perawat Dalam Ketepatan Triase Di Kota Padang', *Indonesian Journal for Health Sciences*, Vol.2(No.1), pp. 1–6.
- Lindayani, D., Nurhidayah, R.E. and Rochadi, R.K. (2024) 'The Relationship Between The Accuracy of Filling Out The Early Warning Score System Form and Nurse Decision Making', *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 6(2), pp. 983–998.
- Meckawy, R. et al. (2022)

- Mackway, J. K., Marsden, J., & Windle, J. (2006). Emergency triage. Manchester
- Mason, Suzane. (2007). Optimizing Triage, Waiting Time And Service Delivery In Busy Emergency Departmen. University Of Sheffield.
- Ministri Of Health.(2012). Emergency Departmen Model Of Care. Emergency Care Institute New South Wales.
- Nieils, *et al.* (2012). Time Series Analysis Of Emergency Department Length Of Stay Per 8-Hour Shif. West Journal Emergency Medicine. May 13 (2) : 163-168.
- Oman, Kathleen., *et al.* (2008). Panduan Belajar Keperawatan Emergency. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Oman, Kathleen., *et al.* (2008). Panduan Belajar Keperawatan Emergency. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Potter dan perry. (2005). Fundamental keperawatan. Jakarta : EGC.
- Sands, N. (2004). *Mental health triage nursing: An Australian perspective. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing*, 11, 150–155.
- Sands, N. (2009).An Exploration of Clinical Decision Making in Mental Health Triage. Archives of Psychiatric Nursing, Vol. 23, No. 4 (August): 298-308.
- Semonin, Holleran. (2008). *Caringfor the Patient in the Emergency Department*. www.bookdev.com. Di akses 7 April 2013.
- Subash F, *et al.* ( 2003). Team Triage Improve Emergency Departmen Efficiency. Emergency Journal 2004;21:542-544.triage group 2nd ed. Blackwell publishing: USA.
- Trisniati, Eni. (2012). Hubungan Pengetahuan Tentang Cidera Kepala dan Peran Perawat Dalam Penanganan

Pasien Cidera Kepala Di IGD RS QADR Tangerang Tahun 2012. [Http/: Digilib. Esaunggul.ac.id](http://Digilib.Esaunggul.ac.id).

Widodo, Panggah dan Pratiwi, Arum. (2008). Hubungan Beban Kerja Dengan Waktu Tanggap Perawat Gawat Darurat Menurut Persepsi Pasien di IGD RSUD Pandan Arang Boyolali. *Bentang Ilmu Keperawatan* ISSN 1979-2697 Vol 1 no 3: 125-130.

Yoon P, Steiner, Reinhardt. (2013). Analysis Of Factor Influecing Length Of Stay In the Emergency Depatmen. <http://www.cnbi.nlm>.

Zimmerman, P. G., & Herr, R. (2006). *Triage Nursing Secrets*. USA: Mosby Elsevier.

## PROFIL PENULIS



**Ns. Novia Wulansari, M.Kep., Sp.Kep.M.B.,**

Merupakan dosen keperawatan di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa dengan bidang ilmu keperawatan Medikal Bedah . Penulis menyelesaikan pendidikan pada strata sarjana di Stikes Borobudur, Profesi keperawatan di Universitas Esa Unggul. Untuk Strata Postgraduate Magister Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis pernah menjadi Perawat di RS PELNI selama 21 tahun, berminat memiliki minat dan pengalaman dalam aktivitas pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat dalam lingkup keperawatan Medikal Bedah.

## PROFIL PENULIS



**Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep.,** Lahir di Medan, 19 Oktober 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKes Surya Global Yogyakarta lulus tahun 2013, dan melanjutkan Program Profesi Ners lulus

pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018, di Universitas Alma Ata Yogyakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2021, pada tahun 2023 hingga saat ini berkerja di Universitas Aisyah Pringsewu. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyah Pringsewu mengampu mata kuliah Keperawatan Bencana, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis, dan Keperawatan Dewasa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [Sugiartoners@gmail.com](mailto:Sugiartoners@gmail.com)

Motto: "Educate with heart, guide with knowledge, and inspire by example"

## PROFIL PENULIS



**Vita Maryah Ardiyani, S.Kep., Ns., M.Kep.,** lahir di Malang, 26 Februari 1987. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Brawijaya Malang Program Studi Ilmu Keperawatan, lulus tahun 2010. Pendidikan S2 Magister Keperawatan Universitas Brawijaya

Peminatan Keperawatan Gawat Darurat, lulus tahun 2015. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang . Penulis sangat mencintai dunia pendidikan tinggi terutama bidang keperawatan yang sudah di geluti selama lebih dari 10 tahun dan aktif dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup perguruan tinggi. Penulis aktif terlibat dalam beberapa penelitian termasuk yang didanai kementerian DIKTI. Beberapa artikel telah diterbitkan penulis pada jurnal bereputasi terutama dalam lingkup keperawatan gawat darurat dan keperawatan medical bedah. Penulis berfokus pada penelitian di area keperawatan gawat darurat khususnya triase. Besar harapan penulis untuk aktif dalam menghasilkan produk artikel, buku dan karya lain yang dapat memberikan manfaat bagi sesama.  
Email : vitamaryah@gmail.com(081336068456).

Buku *"Keperawatan Gawat Darurat: Etika dan Tanggung Jawab dalam Situasi Darurat"* merupakan bunga rampai yang menggali berbagai aspek penting dalam praktik keperawatan di ruang gawat darurat. Didesain untuk menjadi referensi praktis dan reflektif bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya, buku ini memfokuskan pada tantangan nyata yang dihadapi saat bekerja dalam tekanan waktu, ketidakpastian, dan kondisi krisis.

Dalam bagian pertama, pembaca diajak memahami bagaimana prinsip-prinsip etika diaplikasikan secara konkret dalam pengambilan keputusan pada situasi darurat, di mana pilihan sulit dan dilema moral sering kali muncul. Bagian kedua menyoroti pentingnya kerja tim dan kolaborasi antar profesi dalam memastikan keselamatan dan efektivitas penanganan pasien gawat darurat. Sedangkan bagian ketiga membahas peran krusial perawat dalam proses triase—menentukan prioritas perawatan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Melalui kombinasi kajian teori, studi kasus, dan refleksi praktis, buku ini memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai tanggung jawab profesional perawat dalam situasi darurat. Buku ini cocok dibaca oleh mahasiswa keperawatan, perawat praktik lapangan, pendidik, serta siapa pun yang terlibat dalam pelayanan kesehatan gawat darurat.

Buku "Keperawatan Gawat Darurat: Etika dan Tanggung Jawab dalam Situasi Darurat" merupakan bunga rampai yang menggali berbagai aspek penting dalam praktik keperawatan di ruang gawat darurat. Didesain untuk menjadi referensi praktis dan reflektif bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya, buku ini memfokuskan pada tantangan nyata yang dihadapi saat bekerja dalam tekanan waktu, ketidakpastian, dan kondisi krisis.

Dalam bagian pertama, pembaca diajak memahami bagaimana prinsip-prinsip etika diaplikasikan secara konkret dalam pengambilan keputusan pada situasi darurat, di mana pilihan sulit dan dilema moral sering kali muncul. Bagian kedua menyoroti pentingnya kerja tim dan kolaborasi antar profesi dalam memastikan keselamatan dan efektivitas penanganan pasien gawat darurat. Sedangkan bagian ketiga membahas peran krusial perawat dalam proses triase—menentukan prioritas perawatan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Melalui kombinasi kajian teori, studi kasus, dan refleksi praktis, buku ini memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai tanggung jawab profesional perawat dalam situasi darurat. Buku ini cocok dibaca oleh mahasiswa keperawatan, perawat praktik lapangan, pendidik, serta siapa pun yang terlibat dalam pelayanan kesehatan gawat darurat.

Penerbit:

**PT Nuansa Fajar Cemerlang**

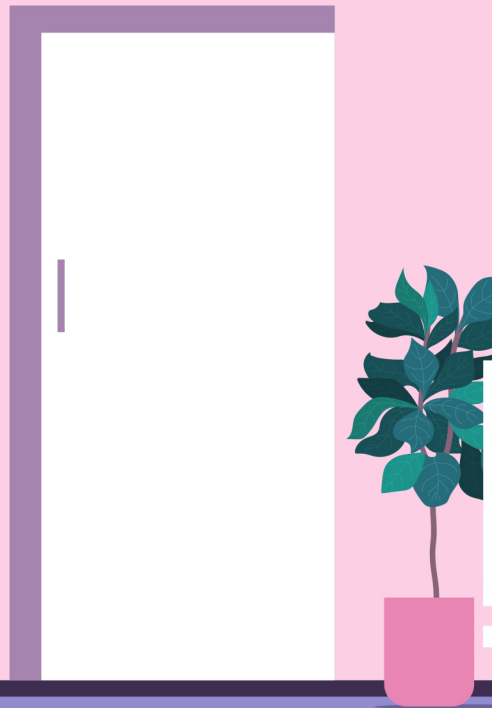
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-25-1



9

786347

219251